

316132

С.М. Шукурова

ГАЗАКГИРИИ БАНДИ
РЕАКТИВӢ
(артритҳои реактивӣ)

Дастури таълимӣ

ДУШАНБЕ-2008

С.М. Шукурова

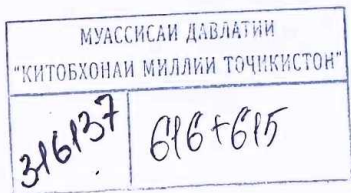
**ГАЗАКГИРИИ БАНДИ
РЕАКТИВӢ
(артритҳои реактивӣ)**

Дастури таълимӣ

ДУШАНБЕ-2008

Мундарича

Номгӯи ихтисорот.....	4
Муқаддима.....	5
Экология ва патогенези бандҳои реактивӣ.....	6
Таснифоти газакгии бандҳои реактивӣ.....	9
Манзараи клиникаи газакгии банди реактивӣ.....	12
Таъхиси газакгии банди реактивӣ.....	18
Таъхиси тафриқотнокии газакгии банди реактивӣ.....	27
Таҳияи таъхиси газакгии банди реактивӣ.....	31
Муолиҷаи газакгии банди реактивӣ.....	32
Таъобати зиддибактериявӣ.....	32
Доруҳои нестероидии зиддибактериявӣ.....	35
Доруҳои глюкокартикоустероидӣ.....	42
Воситаҳои заминавӣ.....	43
Экзимотерапияи системавӣ.....	51
Интерферонотерапия ва индукторҳои интерферонҳо.....	54
Усулҳои иловагӣ.....	55
Алгоритмҳои таъобати газакгии банди реактивӣ.....	56
Таъобати ҷузъӣ.....	58
Табиатшифои.....	61
Бистаргардони ва муоинаи тиббию иҷтимоии беморони гирифтори газакгии банди реактивӣ.....	62
Адабиёт.....	65



000844534

Китобхонаи миллии Тоҷикистон

Сурайё Максудовна Шукурова – доктори илми тиб, профессор, мудири кафедраи бемориҳои дарунии Донишқадаи тақмили ихтисоси баъдидипломии кормандони тибби Тоҷикистон, сармутахассиси бемориҳои тарбод Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Муқарриз: узви вобастаи АИ ҚТ, доктори илми тиб, профессор Н.Х. Ҳамидов

Муқарриз: корманди шоистаи ҚТ, доктори илми тиб, профессор У.Р.Расулов

Дар дастур масъалаҳои этиология, патогенез ва клиникаи газакгии банди реактивӣ баррасӣ гашта, усулҳои муосири таъхису муолиҷаи беморӣ, инчунин масъалаҳои назоратгардонӣ, экспертизаи корношоямии муваққатӣ ва экспертизаи тиббӣю иҷтимоии беморони гирифтори артритҳои реактивӣ пешниҳод гардидаанд.

Дастури таълими барои шунавандагони давраҳои таълимии тақмили ихтисоси духтурон, тарбодшиносон (ревматологҳо), духтурони амалияи умумӣ, донишҷӯёни мактабҳои олии тиббӣ пешбинӣ шудааст.

Барои чоп аз тарафи Шӯрои таъбу нашри Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия дода шудааст.

(Протоколи № аз)

Номгӯи ихтисор

ДНЗИ – доруҳои нестероидии зиддиалтиҳобӣ

СТЭ – суръати тахминии эритроцитҳо

ГБР – газакгирии банди реактивӣ

СОГ – сиклооксигеназа

ГКС – глюкокортикостероидҳо

ИЛ – интерлейкин

ДМСО – диметилсульфоксид

ШУГ – шуои ултрагулобӣ

ГМЛ – табобати магнетию-лазерӣ

ССР – сафедаи С-реактивӣ

МГМ – маҷмӯи гардишкунандаи масунӣ

МУҚҚАДИМА

Газакгирии банди реактивӣ (ГБР) – бемории масунии илтиҳобии банди устухонҳо мебошад, ки ҳамзамон бо раванди илтиҳобӣ ё каме баъдтар аз он пайдо мешавад ва зухуроти клиникӣ системавӣ ин сироят мебошад.

ГБР аз сабаби васеъ паҳн шудани касолати мазкур дар байни бемориҳои дарунӣ, касолатнокшавии одамони синну соли гуногун, аз ҷумла синни қобилияти қорӣ (20-40 сола), гоҳо ба шакли музмин табдилёбии раванд, инчунин мушкilotи муайяни таъхис ва муолиҷаи он мавқеи махсусро ишғол мекунад. Мардҳо назар ба занон аз ГБР бештар ранҷ мекашанд (таносуби 20:1).

Ба таври клиникӣ ГБР бо раванди илтиҳобӣ дар бандҳои ҳурди пойҳо зоҳир мегардад, ки дар баъзе ҳолатҳо бо аломатҳои барои спондилоартропатия (касoлати сутунмӯҳраю бандҳо) хос – энтеропатия ва дард дар шӯъбаҳои поёнии миён ҳамбастагӣ менамояд. Дар баъзе беморон дар баробари артрит конъюнктивит (илтиҳоби мултаҳима) ва уретрит инкишоф меёбад, ки ҳамчун синдроми Рейтер баҳо дода мешавад; дар баъзе ҳолатҳо артрит метавонад дар заминаи дигар падидаҳои системавӣ, ба мисли ирит (илтиҳоби инабия), ярашавии луобпардаи ҳуфраи даҳон, *keratodenna blenorragica*, касолати дил ва системаи асаб ҷараён ёбад.

Маҷмӯи аломатҳо бо касолати бандҳо, ки ҳамчун оризаи исҳоли хунини батсиллярӣ тасвир ёфтааст, ҳанӯз аз қарни V. ҳангоме ки *Celius Avrelianus* "reumatismus intestinalis cum ulcera"-ро тасвир намуда буд, маълум аст. Соли 1965 А.И. Нестеров барои ифода намудани артритҳои шадид, ки инкишофи онҳо бо интиқоли раванди сироятӣ алоқаманд карда мешуд, истилоҳи «полигазакгирии банди сирояӣ-аллергӣ»-ро пешниҳод намуд.

Истилоҳи «газакгирии банди ГБРктивӣ» ҳамчун шакли нозологӣ бори аввал аз тарафи тадқиқотчиёни финӣ Р. Ahvonen К. ва А.һо пешниҳод карда шуд, ки артритро ҳангоми энтероколити пайдоишаш (этиологиаш) иерсиниозӣ тасвир намуда буданд. Ҳамзамон дар назар дошта шуда буд, ки ГБР – ин бемориҳои «бесироятӣ» илтиҳобии бандҳо мебошанд.

ки хангоми он дар моеи зулолӣ ва пардаи зулолии беморон ҳомилони (агентҳои) сироятӣ ва антигенҳои онҳо вучуд надоранд. Вале минбаъд бо ёрии усулҳои ҳозиразамони ташхис нишон дода шуд, ки дар як қатор беморони ГБР на фақат бо антигенҳои бактериявӣ, балки бо микроорганизмҳои барои афзоиш қобилиятдошта зохир мегардад. Масалан, дар синовиотситҳои баъзе аз беморон бо ёрии таҳлили иммунологӣ ва технологияи молекулярӣ муайян намудани ДНК-и бактериявӣ муяссар мегардад, ки барои ҳамчун «сироятӣ» баҳо додани чунин артрит имконият медиҳад. Бо вучуди ин, истилоҳи «газақгирии банди реактивӣ» ҳоло аз тарафи умум қабулшуда мебошад ва дар таснифоти байналхалқии бемориҳои тарбодӣ истифода бурда мешавад.

ЭТИОЛОГИЯ ВА ПАТОГЕНЕЗИ ГАЗАҚГИРИИ БАНДҲОИ РЕАКТИВӢ

Баръакси бисёре аз артритҳои дигар хангоми ГБР алоқамандӣ бо омилҳои хориҷзодӣ барангезанда мавҷуд аст, маркерҳои генетикии он маълуманд ва ҷавоби ҳуҷайравӣ ва гуморалии масунӣ, ки дар бандҳо ба антигени сабабӣ инкишоф меёбад, омӯхта шудааст.

Аз рӯи омилҳои этиологӣ ГБР ба ду гурӯҳ ҷудо карда мешавад: постэнтероколитӣ ва урогениталӣ. Дар байни бактерияҳои касалиоваре (патогенҳое), ки бемориро ба вучуд оварда метавонанд, иерсинҳо, салмонеллаҳо, шигелҳо, кампилобактер ва гайраро ҷудо кардан лозим аст. Барангезандаи асосии ГБР-и урогениталӣ *Chlamidia trachomatis*, ки дар 50-90% беморон ошкор карда мешавад, ҳамчунин *Mycoplasma hominis* ва *Ureaplasma urealyticum* мебошад.

Қайд кардан лозим аст, ки дар давоми 20 соли охир дар таркиби микроорганизмҳое, ки омилҳои этиологӣ ГБР мебошанд, тағйироти муҳиме ба вучуд омаданд. Масалан, бештар сироятҳои хламидиявӣ дучор мегарданд, ҳол он ки басомадаи пайдоиши артритҳои бо иерсинияҳо алоқаманд аз сабаби умуман кам гардидани бемориҳои сиротиӣ рӯдаҳо паст шудааст.

Мафҳуми «газақгирии банди реактивӣ» гоҳо баъзи муайян намудани артритҳое истифода бурда

мешавад, ки бо намудҳои стрептококкӣ, берсиллиозӣ, брутселлезӣ, вирусӣ ва дигар намудҳои сироятҳои алоқманд мебошад. Вале ин гуна бемориҳо дар беморон мавҷуд будани HLA-B27-антиген ва инкишофи спондилоартропатия ҳамбастагӣ намекунанд, аз ин сабаб онҳо минбаъд баррасӣ карда намешаванд.

Дар патогенези ГБР нақши асосиро ихтилоли зинаҳои ҳуҷайравӣ ва гуморалии масуният мебозанд, ки боиси инкишофи гипериммунии организм ба инвазияи (олудашавии) мустақими микроорганизм дар сатҳи банд ё ба сирояти хориҷи банд мегардад. Дар ин маврид микроорганизмҳои метавонанд боиси осебҳои бофтаҳо ё бо роҳи таъсири мустақими захрогин ба ҳуҷайра-ҳуҷаин (таъсири ситопатӣ) гарданд, ё раванди иммунопатологиро (этилоли масуниятро) дар заминаи норасоии мавҷудаи модарзодӣ ва ё иқтисобии масуният (таъсири ғайрситопатӣ) ба қор андозанд. Аз ҷумла, ҳангоми ГБР аз сабаби *Chlamidia trachomatis* ба вучудодада дар фаршчаҳои зулолӣ аксар вақт бактерияҳои зинда муайян карда мешаванд. Зиёда аз ин, дар аксуламалҳои идентификацияи полимеразӣ дар бофтаҳои бандҳо, тибқи маълумоти як қатор тадқиқотчиён, на фақат ДНК-и хламидиягӣ, балки транскриптантҳои нахустини хламидиягии м-РНК муайян карда мешавад. Бо назардошти он ки вақти ними ҳаёти ин транскриптантҳои нахустин хеле кам аст, мавҷуд будани падидаҳои транскриптсия ҳузур доштани хламидияҳои қобили ҳаётӣ ва фаъолро собит менамояд.

Ҳоло он далеле исботшуда мебошад, ки хламидий ва иерсинияҳо барои ангиғиш додани ҷавоби ситотоксикӣ Т-ҳуҷайравӣ қобиланд, дар айни замон нумӯъ ва фаъолноқшавии Т-лимфотситҳои зертудай (субпопулятсияи) CD8+ боиси осебҳои пардаи зулолӣ ва минбаъд инкишоф ёфтани манзараи клиникӣ артрит мегардад. Маҷмӯи масунии ба миқдори зиёд ҳосилшуда дар бофтаи бандҳо тақаррур ёфта, боиси зиёд ҳосилшавии ситокинҳои қабилитиҳобӣ (простогландини Е, интерлейкин -1 α , омилҳои некрози (мавташавии) омосҳои ва ғайра) мегарданд, ки ба индуксия ва нигоҳдошташавии раванди масунию илтиҳобӣ оварда мерасонад.

Дар инкишофи бемориҳои тамоюли генетикӣ аҳамияти муҳим дорад, ки дар ин бораи мутахидии

(ассотсиатсия) зичи ГБР бо антигени НГА-B27 шаҳодат медиҳад, ки ҳангоми артритҳои урогениталӣ дар 80-90% ҳолатҳо ва ҳангоми ГБР-и баъдиэнтероколитӣ – дар 70% ҳолатҳо ошкор карда мешавад. Тибқи гипотезаи мимикрияи антигенӣ, монандии ретсептори байни антигени HLA-B27 ва антигени микробӣ барои устувории дуру дарози он дар организми бемор мусоидат менамояд ва инкишофи раванди аутоиммуниро барангезиш медиҳад. Яке аз механизмҳои инисиатсияи ГБРметавонад воридшавии микдори зиёди антигенҳо тавассути девораи рағҳо ба маҷрои хун дар натиҷаи нифозати баланди рӯдаҳо, ки дар беморони баъдиэнтероколитӣ ва ГБР бо ноқлияти минбаъдаи онҳо ба бофтаҳои бандҳо мушоҳида мегардад, бошад.

Назарияи «пептиди артритогенӣ» нисбатан қобили қабул мебошад, ки мувофиқи он HLA-B27 молекулаи ягонаи маҷмӯи токатпазирии гистологии синфи I мебошад, ки барои пешниҳод намудани пептиди артрит-ҳосилкунанда ё пептидҳои ситотоксикии «Т-лимфотситҳои тӯдаи CD8+ қобилият дорад (нақшаи 1).

Маълум аст, ки пептиди артритогенӣ чӯзӣ ғишои ҳуҷайравии бактерияи сабабнок мебошад, барои равандҳои аутоиммунӣ бошад ҳосилшавии антителасое (зидҷисмное) ҳос аст, ки ҳам ба микроорганизмҳои антигенӣ, ҳам бо осебҳои бофтаҳои худӣ эътино менамоянд. Ҳоло қариб 60 пептидҳои хламидиягӣ маълуманд, ки вобаста ба пайдарҳамии аминокислотагии худ метавонанд бо HLA-B27 алоқаманд гарданд. Зиёда аз ин, исбот карда шудааст, ки яке аз чунин пептидҳо (протеини хит-садмавии 70) қобилияти фаъолнок намудани Т-лимфотситҳои ситотоксикиро дар беморони гирифтори ГБР дорад.

Аз нуктаи назари амалӣ патогенези ГБР-ро шартан ба се марҳила тақсим намудан мумкин аст: иниситасия, ГБР-и шадид ва ГБР-и музмин. Дар марҳилаи иниситасия бемор ба таъсири бактерияҳои барангезанда дучор мегардад, ки ба таври клиникӣ дар шакли сирояти нахустин (энтероколит ё уретрит) бо аломатҳои хоси клиникӣ зоҳир мегардад. Дар бисёре аз беморон шифоёбии пурра бе ягон ҳел оқибатҳо ба вучуд меояд, вале дар баъзе аз онҳо ГБР инкишоф меёбад. Барои марҳилаи ГБР-и шадид инкишофи илтиҳоби ноҳиявии зулолия, аломатҳои касолати сутунмӯҳраю

бандҳо (спондилоартропатия) бошад асосан дар ҳомилони антигени HLA- B27 инкишоф меёбанд. Дар ҳолати ГБР-и музмин ба мисли пештара ҷудокунии байни беморони HLA-B27-позитивӣ ва HLA- B27-негативӣ нигоҳ дошта мешавад, вале дар беморони HLA-B27-позитивӣ эҳтимолияти баланди инкишофи шаклҳои вазнин ва хуруҷкунандаи беморӣ вучуд дорад.

Накшаи 1

ПАТОГЕНЕЗИ ГАЗАКГИРИИ БАНДИ РЕАКТИВӢ

Омили этиологӣ (хламидияҳо, микоплазма, уреоплазма, иерсиния, шигелҳо, салмонеллаҳо ва ғайра

Тамоюли генетикӣ
(мавҷудияти антигени HLA- B27)

Пептиди артритогенӣ
(Протеини хит-садмавии 70)

Нумӯъ ва фаъолноқшавии Т-лимфоситҳои ситотоксикӣ (CD+8)

Ҳосилшавии зиёди ситоконҳои каблилтиҳобӣ (Ил-1, Ил-6, ФНО ва ғайра

Осебёбии пардаи зулолии бандҳо

Синтези аутоантителаҳо ҳосилшавии СИК

Раванди масунию илтиҳобӣ

Зоҳиршавии клиникӣ
Ғазакгирии банди реактивӣ

ТАСНИФОТИ ГАЗАКГИРИИ БАНДИ РЕАКТИВӢ

Чи хеле ки қайд карда шуд, ба гурӯҳи ГБР баъзе аз муаллифони артритҳои баъдиэнтероколитӣ,

урогениталӣ, инчунин артритхоеро дохил менамоянд, ки баъди сироятҳои вирусӣ, ҳангоми бемориҳои саратонии хун (онкогематологӣ), инчунин баъдивактсинали инкишоф меёбанд. Дар баробари ин солҳои охир тамоюли дақиқи ба ГБР дохил намудани фақат беморӣҳои мушоҳида мешавад, ки баъди сирояти рӯдаҳо ё роҳҳои пешоб инкишоф меёбанд ва бо антигени HLA-B27 муштарак мебошанд. Мо дар ин ҷо таснифоти ГБР-ро меоварем, ки ба фикри мо барои кори амалӣ нисбатан беҳтар аст.

ГБР тақсим мешавад:

1. Аз рӯи этиология:

1.1. HLA-B27 – муштарак:

- баъдиэнтероколитӣ (иерсиниозӣ, салмонеллезӣ, шигеллезӣ ва ғайра)
- уrogenиталӣ (хламидиягӣ, микоплазмавӣ, уГБРплазмавӣ);

1.2. Бо антигени HLA-B27 муштаракнабуда;

- баъди сирояти ҳалқум, баъди сирояти вирусӣ;
- баъди бемориҳои саратонӣ ва гематологӣ;
- баъдивактсинали

2. Аз рӯи чараёнбӣ:

- шадид (давомнокии ҳамлаи нахустини бандҳо то 2 моҳ);
- тӯлкашида (давомнокии беморӣ то 1 сол);
- музмин (давомнокии беморӣ зиёда аз 1 сол);
- хуруҷкунанда (ҳангоми инкишофи ҳамлаи бандҳо баъди такроршавии (ремиссия) бемории давомнокиаш на камтар аз 6 моҳ);

3. Аз рӯи дараҷаи фаъолнокӣ:

- паст (I);
- миёна (II);
- баланд (III);
- ремиссия (0)

4. Аз рӯи дараҷаи норасоии функционалии бандҳо (НФБ):

- қобилияти касбӣ нигоҳ дошта шудааст;
- қобилияти касбӣ аз даст рафтааст;
- қобилияти худхизматрасонӣ аз даст рафтааст.

Дараҷаи фаъолнокии ГБР дар асоси нишондиҳандаҳои клиникаю лабораторие муайян карда мешавад, ки қисми асосии онҳо дар таблитсаи 1 оварда шудаанд.

Таблитсаи 1
Нишондиҳандаҳои фаъолнокии газакгирии банди реактивӣ

Аломат	Фаъолнокӣ			
	I	II	III	0
Шиддатнокии дард дар бандҳо, баллҳо	1	2	3	0
Шиддатнокии дард дар бандҳо аз рӯи чадвал визуалии 10 см	1-3	4-6	7-10	0
Гемоглобин, г/л	129-120	119-110	камтар аз 109	зиёдтар аз 30
СТЭ, мм/соат	11-20	21-40	зиёдтар аз 40	камтар аз 10
Сафедаи С-ГБРктивӣ	+	++	+++	0
Фибриноген	4-5	5-6	зиёда аз 6	2-4

Шиддатнокии дард дар бандҳо аз рӯи чадвали 4-балла баҳо дода мешавад:

0 – набудани дардҳо;

1 балл – дарди минималӣ, ки сабаби паст шдани қобилияти меҳнати бемор намегардад, ба хоб халал

намерасонад;

2 балл – дарди муътадил; қобилияти меҳнати беморро паст мекунад ва худхизматрасони ро маҳдуд месозад, тавассути аналгетикҳо табобат карда мешавад;

3 балл – пурзӯр, дарди қариб доимӣ, аксаран ба ҳоб ҳалал расонанда, бо доруҳои зиддиалтиҳобии нестероидӣ суст бартараф карда мешавад. Чунин дард метавонад сабаби пурра аз даст додани қобилияти меҳнати касбӣ ва маиши бемор гардад.

Шиддатнокии дарди бандҳо ҳамчунин аз рӯи «градатсияи дард тибқи чадвали 10 см» баҳо дода шавад. Методикаи баҳодиҳӣ чунин аст: дар варақи қоғаз сутуни рост бо нишонаҳои сантиметрии аз 0 то 10 мекашанд ва ба бемор таклиф менамоянд, ки дарди аз ҳама сахтаринро (аз рӯи эҳсоси шахсӣ) ба хотир оварад, ки боре дар ҳаёташ ҳис карда буд, масалан баъди зарба, афтидан, осебёбӣ ва ғайра. Шиддатнокии чунин дард 10 см, набудани дард – 0 см қабул карда мешавад. Ҳангоми дард дар бандҳо бемор онҳоро бо дарди аз ҳама сахтарини собиқаи беморӣ (анамнез) муқоиса менамояд ва дар чадвали сантиметрӣ миқдори сантиметрҳои ба шиддатнокии синдроми дард мувофиқро мегузорад. Методикаи мазкур барои ба дараҷаи муайян дарҷ намудани эҳсосоти шахсии бемор имконият медиҳад, ки барои баҳодиҳии динамикаи синдроми бандҳо имконият медиҳад.

МАНЗАРАИ КЛИНИКИИ ГАЗАКГИРИИ БАНДИ РЕАКТИВӢ

Дар манзараи клиникии ГБР касолати дастҳои такаву ҳаракат асосӣ мебошад, вале баъзе хусусиятҳои қараёнёбӣ вобаста ба омили этиологӣ мавҷуданд. Инкишофи ГБР-и баъдиэнтероколитӣ чун қоида бо ҳуруҷҳои эпидемиявии сирояти рӯдаҳо алоқаманд аст.

Зоҳиршавии сирояти шадиди рӯдаҳо на зиёдтар аз 1-2 ҳафта давом мекунад ва метавонад мустақилона бе истифодаи табобати зиддибактериявӣ бартараф гардад. Артрит баъди 1-3 ҳафтаи пас аз энтероколит ва хеле кам ҳамзамон бо он инкишоф меёбад. Оғози он шадид, бо мавзёгирии хос дар бандҳои пойҳо мебошад, вале метавонад бандҳои хурди дасту панча, беҳи панча ва оринҷ ҷалб шаванд. Гоҳо конъюнктивит, тағйиротҳои пӯст аз рӯи навъи эритемаи уқдадор, тендовагинит ва бурсит инкишоф меёбад. Дар аксари ҳолатҳо инкишофи пурраи бозпаси артрит мушоҳида карда мешавад, вале гоҳо беморӣ хусусиятҳои ГБР-и музминро мегирад.

ГБР-и урогениталӣ баъди 1-6 ҳафтаи пас аз манифестатсияи сирояти роҳҳои пешоб инкишоф меёбад. Синдроми бандҳо бо ба раванд ҷалбшавии бандҳои калони пойҳо – зону ва кафи пой – аз рӯи навъи ассиметрии моно- ё олигоартрит тавсиф меёбад. Ҳангоми шиддатёбии раванди илтиҳобӣ касолати зиёди бандҳо бо пайдарҳам ҷалбшавии онҳо ба раванди илтиҳобӣ аз поён ба боло (навъи «нардбонмонанд»- и касолат) имконият дорад. Нисбатан бештар бандҳои хурди пай бо инкишофи шаклдигаркунии (дефигуратсияи) «ҳасибчамонанд»-и ангуштон аз ҳисоби омоси параартикулярӣ ҷалб карда мешаванд. Пӯсти болои банди касолатёфта сурхранг ё кабудча шуда, ҳарорати он баланд мешавад. Дар баробари бандҳо пайвандҳо, рағҳои маҳбал, ҳалтачаҳои луобӣ ва устухонпардаҳо касолатнок мешаванд. Нисбатан бештар бурсити поении бучулаки пой, фастсиити зехи по, ахиллобурсит ва дардҳои бо он алокманд дар қисмати пай дучор мегарданд, ки боиси тағйирёбии тарзи роҳгардии беморон мегардад. Аз сабаби касолати бандҳои хурди ва дастгоҳи пайвандии пайҳо бо гузашти вақт панҷаи «пахн» шакл мегирад. Ҳангоми периостити инкишофёбанда дарднокии сатҳи болои

устухон қисмати наздибандҳо пайдо мешавад.

Дар беморони гирифтори ГБР аксаран касолати пӯст ва луобпардаҳо дар шакли баланит, баланопостит, эрозияҳои камдарди луоби хуфраи дахон мушоҳида карда мешавад. Касолати пайвасти тихигоҳу чорбанд – сакроилеит – асосан дар беморони гирифтори чараёни музмини ГБР таъхис карда мешавад.

Падидаҳои нисбатан бештар дучоршавандаи хориҷибандии ГБР вараҷа, лимфоденопатияи ноҳиявӣ, камшавии вазни бадан, гипотрофияи мушакҳо, камхунӣ нормо- ва гипохромӣ мебошанд. Лимфоаденопатияи ноҳиявӣ асосан дар беморони гирифтори чараёни музмини ГБР таъхис карда мешавад. Нисбатан бештар лимфаденопатияи зер- ва болоиқулфакӣ, зерибғалӣ ва қадкашак касолатнок мегарданд; дар ин маврид зохиршавии лимфаденопатия аз фаъолнокии раванди масунию илтиҳобӣ вобастагӣ дорад. Андозаи укдалимфаҳо аз 1 то 3 см-ро таъхил медиҳад, онҳо чун ўида, зичии мўтадил дошта, дарднок нестанд, ба пӯст наҷаспида мебошанд, бо осонӣ беҷо шуда метавонанд.

Синдроми камхунӣ нисбатан бештар дар беморони гирифтори чараёнёбии тўлкашида ва/ё музмини ГБР инкишоф меёбад, дар айни замон сухан дар бораи «камхунӣ илтиҳобии музмин» (КИМ) меравад, ки патогенези он бисёрсабабӣ (полиэтиологӣ) мебошад. Яке аз сабабҳои инкишофи КИМ паст намудани фаъолнокии функционалии хучайраҳо-пешгузаштагони эритропоз мебошад, ки дар натиҷа иктидоринумӣ онҳо паст мешавад, равандҳои тафриқакунонӣ ва синтези гемм ҳалалдор мегардад. То ҳол маълум нест, ки ингибаторҳои гемопоз бевосита ба хучайраи хунофари полипотентии шоҳагӣ таъсир мерасонанд ё таъсири онҳо ба қатори нумўқунандаи хучайраҳо-пешгузаштагони эритроидӣ равона шудааст.

Омили дуҷоми муҳим дар инкишофи камхунӣ – ҳалалдор шудани мубодила ва партовтозакунии оҳан мебошад, ки бо пастшавии фурубарии оҳан ва кам шудани пайвастании оҳан дар узвҳо ва ҳучайраҳои системаи ретикулоэндотелиалӣ ва сустшавии ба мағзи устухон воридшавии норасоии бо ном «функционалии» оҳан зоҳир мегардад. Кам шудани истехсоли эритропоини эндогенӣ ва қобилияти нокифояи мағзи устухон ба истехсоли комилан мувофиқи эритроцитҳо ҳамчунин омилҳои бемориовари (патогении) КИМ мебошанд.

Аз касолатҳои мағзисарӣ ҳангоми ГБР метавонад миокардит бо инкишофи муҳосираи атрио-вентикюлярии дараҷаи гуногун, перикардит дучор оянд, ки нисбатан мусоид ҷараён меёбанд ва боиси инкишофи норасоии дил намегарданд. Гоҳо аортит бо ташаккули норасоии аортавӣ мушоҳида карда мешавад. Ҳангоми ҷараёни дуру дарози ГБР бо дараҷаи баланди фаъолнокӣ инкишофи гломерулонефрит, амилоидози гурдаҳо, инчунин полинейропатия имкон дорад.

Синдроми Рейтер (бемории Рейтер, синдроми уретро-окуло-зулолӣ) (ҳоло ҳамчун яке аз вариантҳои ГБР баррасӣ карда мешавад. Қайд кардан лозим аст, ки басомади инкишофи синдроми Рейтер дар мардон ва занон амалан якхела аст (таносуби 1:1). Ду шакли беморӣ маълум аст – *спорадикий (зӯҳравӣ)*, ки ҳангоми сироятнокшавӣ бо *Chlamidia trachomatis* ва *эпидемиявӣ*, ки аз иерсинияҳо, шигеллаҳо, салмонеллаҳо ва гайра ба вучуд меояд.

Ба таври клиникӣ синдроми Рейтер бо олиго (норасоии)- ё моногазакгирии банди серонегативии ассиметрӣ бо уретрит (простатит дар мардҳо ва вагинит ё сервитсит дар занҳо) ва аломатҳои ҷашм (илтиҳоби мултаҳима, илтиҳоби пеши машина) – «сегонаи классикии Рейтер» зоҳир мегардад. Ҳангоми мавҷуд

будани касолатҳои пӯст ва луобпарда (багинит, кератодермия, ярашавии луоби хуфраи дахон ва ғайра) «сегонаи Рейтер» таъхис карда мешавад. Дар бсиёре аз беморони гирифтори синдроми Рейтер антегени HLA-B 27 ошкор карда мешавад.

Падидаҳои аввалини клиникии беморӣ баъди 2-4 ҳафтаи сирояти гузарондашуда пайдо мешаванд. Барои марҳилаи мунташири беморӣ касолати бандҳо хос аст, ки чун қоида характери ассиметрӣ дорад, дар ин маврид ба раванди касолатӣ бандҳои калони пойҳо (зону, соку панҷаи по), бандҳои панҷаи по, гоҳо бандҳои калони дастҳо ҷалб мешаванд. Пайдо шудани энтезопатия (касoлати пайҳо) бо инкишофи раванди илтиҳобӣ дар ҷойҳои мустаҳкам шудани пай ба устухон алоқманд аст. Эрозияи бандҳо хос нест, вале пайдо шудани онҳо ҳангоми ҷараёни музмини беморӣ имкон дорад.

Аз падидаҳои хориҷибандӣ дар беморони гирифтори синдроми Рейтер инкишофи вараҷа, касолати ҷашмҳо (илтиҳоби мултаҳима, увеит, эписклерит), ихроҷҳои бечошаванда аз уретра имкон дорад, гоҳо баланити ҳалқамонанд таъхис карда мешавад. Ҳамчунин кератодермия, гиперкератози нохунҳо, ахиллобурсид ва фастсиити қафи по мушоҳида карда мешавад. Дар 40%-и беморон сакроилеит таъхис карда мешавад, ки бо як қатор аломатҳо зоҳир мешавад:

- Аломати Кушелевский (I): бемор ба пӯшт дар ҷои саҳт меҳобад, ҳангоми бо қафи дасти духтур зер кардани барҷастагии устухони тихигоҳи бемор дар муддати як дақиқа дард дар мафсили тихигоҳу ҷорбанди касолатёфта пайдо мешавад;
- Аломати Кушелевский (II): бемор ба паҳлӯ дар нимкати (кушеткаи) саҳт

мехобад, духтур бо харду даст дар муддати як дақиқа ба барчастигии устухони тихигохи бемор фишор меоварад, дар ин маврид дар тарафи касолат дард пайдо мешавад;

Аломати Кушелевский (III): бемор ба тахтапушт хобидааст, як пояш ба банди зону қатъ карда шуда, ба як тараф бурда шудааст, дар ин маврид кафи пой ба як тараф бурдашуда ба сатҳи пеши банди зонуи дигар, ки дар ҳолати рост қарор дорад, гузошта мешавад. Духтур ба банди зонуи қатъкардашуда боғайратона фишор оварад, ўро ба нимкат зер мекунад, духтури дигар бошад ба барчастигии устухони тихигохи тарафи муқобил фишор меоварад – бемор дардро дар мафсили касолатёфтаи тихигоҳу чорбанд эҳсос менамояд.

346137 Давомнокии ҳодисаҳои нахустини ГБР ба ҳисоби миёна 3-6 моҳро ташкил медиҳад; вале аксаран аломатҳои клиникаи беморӣ то 12 моҳ ва зиёдтар нигоҳ дошта мешаванд. Ҳангоми ГБР-и урогениталӣ, ва махсусан дар беморони гирифтори синдроми Рейтер, бештар майл доштан ба хуруҷкунии бештари беморӣ мушоҳида карда мешавад, ки ҳам ҳамчун имконияти азнавсироятнокшавӣ, ҳам сирояти устувори хламидиинӣ (микроплазмавӣ, уГБРплазмавӣ) шарҳ дода мешавад. Хуруҷҳо, чун қоида, бо синдроми бандҳо, касолати чашм, пӯст ва луобпардаҳо, уретрит чараён меёбанд.

Дар 20-30% беморони ГБР-и пайдоишаш хламидиинӣ чараёнёбии музмини беморӣ, айни замон дар 15-20% онҳо – талафёбии устувори коибلياتи меҳнатӣ мушоҳида карда мешавад. Дар чунин беморон

аксаран газакгирии банди хуручкунанда, энтезопатия, ирит, иридоциклит, касолати мафсили тихигоҳу чорбанд, спондилити шахшуда инкишоф меёбад.

ТАШХИСИ ГАЗАКГИРИИ БАНДИ РЕАКТИВӢ

Барои ташхиси ГБР пурра аниқ намудани шикоятҳои бемор, анамнези дуруст ҷамъовардашуда, тадқиқи муфасссали системаи банду мушакҳо, тадқиқи воқеъ, инчунин истифодаи усулҳои мувофиқи иловагии (лабораторӣ, инструменталӣ) муоинаи бемор аҳамияти муҳим дорад.

Барномаи ташхиси лаборатории ГБР тадқиқ намудани хуни ноҳиявӣ ва пешоби бемор, моеи зулолӣ, намунаҳо аз масона (уретра), канали гарданӣ, мултаҳима, кишти фазла бо мақсади идентификатсияи омили этиологиро дар бар мегирад. Инчунин усулҳои бактериологӣ, серологӣ ва иммуноферментии тадқиқот истифода бурда мешавад. Нишондиҳандаҳои биохимиявӣ ва иммунологӣ асосан барои мӯян намудани ғаъолнокии ГБР хизмат мерасонанд.

Ҳангоми тадқиқи хуни ноҳиявии беморони гирифтори ҷараёни шадиди ГБР лейкоцитозии нейтрофилӣ ва СТЭ-и баланд мушоҳида карда мешавад. Ҳангоми музминшавии раванд дар баробари тез шудани СТЭ дар беморон гоҳе камхунӣ ташхис карда мешавад, дар ин маврид паст шудани ҷамъшавии гемоглобини хуни ноҳиявӣ ба андозаи зиёд шудани ғаъолнокии ГБР мушоҳида карда мешавад. Синдроми камхунӣ дар ин маврид ҳамчун падидаи системавии беморӣ баррасӣ мегардад, ки ҳатман бояд дар ташхис низ инъикос ёбад. Камхунӣ бо нормо-ё гипохромия, микротситоз, ба таври муътадил паст шудани миқдори оҳан дар зардоби хункам шудани аз трансферин сершавии оҳан, баланд шудани қоиблияти умумии

оҳанпайвасткунандаи зардоби хун ва чамъшавии ферритин тавсиф меёбад.

Дар баробари ин, агар дар бемори гирифтори ГБР камхунӣ ошкор карда шавад ва аломатҳои клиникаи лаборатории норасоии оҳан мавҷуд бошанд, пас тадқиқи клиникаи инструменталии узвҳои роҳи меъдаву рӯда барои истисно намудани хунравии нӣҳони меъдаву рӯда, ки метавонад аз қабули дуру дарози доруҳои нестероидии зиддиалтиҳобӣ ва глюкокортикоидҳо барангезиш ёбад, ҳатмӣ аст. Дар чунин ҳолатҳо ба ҳисоб гирифтани миқдори ретикулотситҳо дар хуни ноҳиявӣ муҳим аст – миқдори онҳо (ҳангоми меёр 1,0-1,5%) ҳангоми инкишоф ёфтани гемолиз ва хунравӣ зиёд мешавад.

Миқдори тромбоцитҳо дар беморони гирифтори ГБР бо фаъолнокии баланди беморӣ метавонад каме баланд шавад (ҳангоми меёр 180-400x10 /л), тромбоцитопения хеле кам инкишоф меёбад ва одатан характери аутоиммунӣ ё ятрогенӣ дорад.

Ба таври муътадил зиёдшавии миқдори эозинофилҳои хуни ноҳиявӣ дар баъзе аз беморон дар заминаи таобати зиддибактериявӣ мушоҳида карда мешавад.

Ҳангоми тадқиқи пешоб дар беморони гирифтори ГБР-и урогениталӣ метавонанд тағйиротҳои таҳшини пешоб (лейкотситҳо ва эритроцитурӣ, инчунин бактриипиурӣ) чой дошта метавонад.

Нишондиҳандаҳои асосии биохимиявии хун дар беморони гирифтори ГБР ҳангоми набудани касолати ҳамроҳикунанда одатан тағйир намеёбанд. Дар баробари ин ҳангоми мавҷуд будани падидаҳои илтиҳобии бандҳо баландшавии миқдори сафедаҳои «шадидмарҳила» - сафедаи С-ГБРктиви (ССР), фибриноген ва кислотаи сиаловӣ мушоҳида карда мешавад. ССР дар бисёре аз аксуламалҳои масунӣ

иштирок намуда, фаъолнокии хоссаи антигении Т-лимфотситҳоро ба таъхир меандозад, С-чӯзӣи комплементро (алексинро) фаъол менамояд ва ғайра. Дарачаи зиёдшавии микдори ССР дар баробари дигар нишондиҳандаҳои лабораторӣ ва клиникӣ нишондиҳандаи муҳим барои муайян намудани дараҷаи фаъолнокии ГБР мебошад.

Ҳангоми зиёд шудани фаъолнокии илтиҳобии беморӣ баланд шудани микдори сафедаи умумӣ ва аз ҷумла қисмати глобулинӣ мушоҳида карда мешавад. Протеинограммаи беморони гирифтори ГБР бо баланд шудани микдори глобулинҳо тавсиф меёбад, ки ғуншавии онҳо бо фаъолнокии раванди масунию илтиҳобӣ ба танзим дароварда мешавад. Дар ҳуни беморон ҳамчунин ғуншавии серулоплазмин, трансферин, ферритин ва лактоферрин зиёд мешавад.

Омӯзиши вазъи масунии беморони гирифтори ГБР баҳодиҳии фаъолнокии функционалии фаготситҳои моноклеарӣ (мутаҳаррикӣ, фаъолнокии фаготситарӣ ва микроботсидӣ, ҳолати равандҳои мубодилавӣ, истехсол намудани онҳо ҳангоми ситокинҳои каблиилтиҳобӣ – Ил-1в, Ил-6, Ил-9, ФНО-а ва ғайра), инчунин Т- ва Вараҷаи тропикӣ-системаи масуниятро дар бар мегирад. Микдори Т-лимфотситҳо ва зертӯдаи онҳо муайян карда мешавад, тадқиқи пролиферативии ҷавоби лимфотситҳо ба алергенҳо ё митогенҳои ғайрихосса – фитогемагглютинин (ФГА) ва конканавалин-А (Кон-А), дараҷаи Ил-2, интерферонҳо эндогенӣ ва дигар усулҳо гузаронда мешавад.

Барои муайян намудани микдори Т-лимфотситҳо ва зертӯдаи онҳо усули иммунофлюоресцентӣ бо антителаҳои моноклиналӣ (АТМК), ки ба антигенҳои тафрикаркардашудаи ҳуҷайраҳо гирифта шудаанд. Дар беморони гирифтори ГБР дар дохили пулаи Т-ҳуҷайраҳо (СОЗ+) зиёдшавии микдор ва фаъолнокии Т-

лимфотситҳои ситотоксикӣ (CD8+) мушоҳида карда мешавад.

Яке аз усулҳои муайян кардани ҳолати функционалии Т-лимфотситҳо аксуламали бластгран бо форматсияи лимфотситҳо (АБТЛ) мебошад. Ин аксуламал барои ошкор намудани қобилияти Т-лимфотситҳо барои ҷавоб додан ба таҳвил (трансформатсия) дар ҳуҷайраҳои бластӣ бо ҳузур доштани митогенҳо (ФГА, Кон-А), антигенҳо, ки нисбати онҳо организм муҳассис мебошад, инчунин лимфотситҳои бегона имконият медиҳад.

Усули нисбатан паҳншудаи муайян намудани ҳолати функционалии Т-системаи масуният аксуламали боз доштани муҳочирати лейкоцитҳо (АБМЛ) бо ҳузури ФГА, Кон-А ё антигенҳо мебошад. Асоси АБМЛ-ро қобилияти Т-лимфотситҳо бо таъсири омилҳои барангезанда дар муҳити кишт ҷудо намудани ситокинҳо, инчунин омилҳои мебошад, ки муҳочирати макрофагҳо ва лейкоцитҳоро устувор менамоянд. Ҳангоми мавҷуд набудани муҳассисшавии лимфотситҳо АБМЛ ҳангоми ворид намудани антигени мазкур мушоҳида карда намешавад. Ин аксуламал мувозӣ бо АБТЛ иҷро карда шуда, натиҷаҳо ҳамеша дар динамика баҳо дода мешаванд.

Барои баҳо додани ҳолати функционалии системаи масунияти гуморалӣ муайянкунии миқдории иммуноглобулинҳо (Ig) дар плазмаи хун истифода бурда мешавад. Хусусияти асосии биологии Ig аз эътино намудани ба маводҳои антигени бегона, системаи комплемент иборат мебошад. Дар зардоби хуни беморони гирифтори ҷараёни музмини ГБР баландшавии миқдори ҳамаи синфҳои иммуноглобулинҳо – А, М, G муайян карда шуда метавонад.

Ташаккули аксуламалҳои иммунопатологӣ

хангоми ГБР бо ҳосил шудани маҷмӯъҳои ҳалшавандаи антиген-антитело, маҷмӯи гардишкунандаи масунӣ (МГМ) алоқаманд аст. Аҳамияти клиники МГМ аз он иборат аст, ки хангоми ҷамъшавии зиёди онҳо хатари инкишофи касолатҳои системавӣ баланд мешавад, дараҷаи он дар хун бошад нишондиҳандаи фаъолнокии беморӣ мебошад. Ғайр аз ин, омӯзиши миқдори МГМ дар динамика (инкишоф) барои баҳо додан ба самаранокии табobati гузарондашуда имконият медиҳад.

Ҳангоми мавҷуд будани зулолии банди зону тадқиқ намудани моеи зулолӣ мебошад, ки тавассути сӯзанхалонӣ (пунксия) ба даст оварда мешавад. Дар беморони гирифтори ГБР зиёд шудани ситози моеи зулолӣ (хангоми шаклҳои шадид лейкоцитҳои нейтрофилӣ, хангоми музмин – лимфотсит ва моноцитҳо бартарӣ доранд) мушоҳида карда мешавад, он тираранг, камтар ҷаспанда мегардад, миқдори сафеда ва комплемент зиёд мешавад. Ҳангоми дар моеи зулолӣ мавҷуд будани антителаҳо (зидҷисмҳо) ба хламидияҳо онҳоро бо ёрии аксуламали иммунофлюоресцентсия ошкор намудан мумкин аст.

Ташҳиси этиологӣ. Дар қисме аз беморони гирифтори ГБР-и баъдиэнтероколитӣ хангоми кишти фазла ба гурӯҳи бесироятгардонӣ (дизгруппа) микрофлораи бемориовар (патогенӣ) мушоҳида карда мешавад. Ҳангоми тадқиқи серологии ошкор намудани (зидҷисмҳо) дар РКГА нисбат ба иерсинияҳо, салмонеллаҳо, шигеллаҳо, кампило-бактерияҳо ва дигар микроорганизмҳо дар титрҳои ташҳисӣ антителаҳои мувофиқ муайян карда мешаванд (1:200 ва зиёдтар). Микроскопияи намунаҳо аз масона, канали сервикалӣ, мултаҳима дар баъзе ҳолатҳо барои ташҳис намудани сироятҳои хламидиявӣ, уреоплазмавӣ, микроплазмавӣ ё ҳамбастагии якчанд барангезандаҳо имконият медиҳад.

Барои мустақиман ошкор намудани антигенҳои хламидиявӣ усулҳои кишткунӣ (културалӣ), ситологӣ, мустақим ва ғайримустақими иммунофлюоресцентсӣ, инчунин иммуноферментӣ ва ПСР-таҳлилҳо истифода бурда мешавад. Вале усулҳои муайян намудани барангезанда маҳдудиятҳои доранд, ки аксаран бо дастрас набудани сарчашмаи сироят барои гирифтани биомавод асоснок гардидаанд. Дар чунин ҳолатҳо мавҷудияти сирояти хламидиявӣ фақат бо ёрии ошкор намудани антителиҳои хоссаи зардобӣ муқаррар карда мешавад. Дар сероташҳиси хламидиозҳо муайян намудани иммуноглобулинҳои синфи А, G, M ба детерминантҳои антигении гуногуни хламидияҳо истифода бурда мешавад.

Дар марҳилаи барвақтии ҷавоби масунӣ (марҳилаи шадид) одатан IgM ошкор карда мешавад. Қуллаи ҷамъшавӣ ба ҳафтаи 2-юми сироят рост меояд, сипас титр тадриҷан паст мешавад ва баъди 2,5-3 моҳ IgM-ҳои хосса дар хун ошкор карда намешаванд.

IgG тақрибан баъди як моҳ пас аз оғози беморӣ ошкор карда мешаванд ва ба дараҷаи кам дар муддати якчанд сол ошкор шуда метавонанд. IgA дар охири моҳи авали сироят дар хун пайдо мешавад ва то он даме ошкор карда мешавад, ки антигени хламидиявӣ барои ҳуҷайраҳои иммунокомпетентӣ дастрас мемонад.

Усулҳои инструменталии тадқиқот усулҳои рентгенологӣ ва ултрасадоӣ, стсинтиграфия, артроскопия, фиброколоноскопия ва ғайраро дар бар мегиранд.

Ҳангоми рентгенографияи бандҳои касолатёфта дар марҳилаҳои барвақтии беморӣ одатан омоси бофтаҳои наздибандӣ ва васеъшавии роғи бандҳо бо мавҷуд будани синовит ошкор карда мешавад. Ҳангоми вариантҳои тўлкашида ва музмини ҷараёнёбии ГБР остеопорози эпифизарӣ, периоститҳо, азнавсозии

кистамонанд дар эпифизҳои устухонҳо, номияҳои устухон дар ҷойҳои мустаҳкамшавии пайи аххилӣ ва устухонпардаи кафи по ошкор карда мешавад. Касолати эрозиявии сатҳи бандҳо метавонад ҳангоми вариантҳои музмини ҷараёнбӣи ГБР инкишоф ёбад, дар айни замон басомади онҳо дар беморони HLA-B27-позитивии гирифтори синдроми Рейтер зиёдтар аст.

Ҳангоми ҷараёни музмини ГБР тақрибан дар 25% беморони HLA-B27-позитивӣ касолати ассиметрии мафсили тихигоҳу ҷорбанд мушоҳида карда мешавад. Ҳангоми рентгенографияи сутунмӯҳра дар 20% беморон аломатҳои спондилит, энтезит, гоҳо – анкилоз бо ташаккули синдесмофитҳои калони ғайриканорӣ ошкор карда мешавад.

Аз усулҳои нави ташхисӣ томографияи компютерӣ ва ЯМР-томографияро қайд кардан лозим аст. Истифодаи ин усулҳо барои ошкор намудани тағйироти устухонҳо ва бофтаҳои наздибандҳо имконият медиҳад, ки визуализатсияи онҳо ҳангоми иҷрои ретгенографияи муқаррарӣ имкон надорад.

Барои ташхиси синовит ва ошкор намудани тағйиротҳои касолатӣ дар устухонҳои скелет стсинтиграфия – усули ташхиси шуӣ, истифода бурда мешавад, ки бо баҳодиҳии доруи радио фарматсевтӣ (технетсий ^{99m}Tc) дар узв ё бофтаи омӯхташаванда асос ёфтааст. Ҳангоми илтиҳоби ғаъоли пардаи зулолии банд ҳангоми ГБР ғуншавии зиёди омехтаи (диффузии) технетсияи радиоғаъол, ҳангоми сакроилеит – тақаррури зиёди (гиперфиксатсияи) он дар қисмати мафсили тихигоҳу ҷорбанд мушоҳида карда мешавад. Усули стсинтиграфияи бандҳо бо ҳассосияти баланд тавсиф меёбад ва дар бисёр ҳолатҳо аз рӯи вақт аз пайдо шудани тағйиротҳои рентгенологӣ пештар воқеъ мегардад.

Солҳои охир барои тадқиқи бандҳо нисбатан

васеътар усули сканеркунии ултрасадоии бандҳо истифода бурда мешавад. Бо ёрии вай он сохторҳои анатомиро ошкор кардан мумкин аст, ки барои тадқиқ бо дигар усулҳо чандон дастрас нестанд. Сканеркунии ултрасадоӣ барои ташҳис намудани тарашиҳои минималии бандҳо, дар инкишоф (динамика) муайян намудани ҳолати пардаи зулолӣ, тағояк ва ғилофаки бандҳо, барои ошкор намудани тағҳои устухонҳои кафи по, ғафсшавии пай, мушакҳои атроф ва ғайра имконият медиҳад.

Барои ташҳиси характери касолати бандҳо ҳамчунин усулҳои махсуси тадқиқ ва аз ҷумла артроскопия истифода бурда мешавад. Тадқиқи ошқори сатҳи бандҳо барои муфассал омӯхтани тағйиротҳои барои дигар усулҳои ташҳисӣ дастнорас имконият медиҳад.

Нисбатан бештар артроскопия ҳангоми касолати бандҳои зону гузаронда мешавад, ки ба туфайли хусусиятҳои анатомии худ барои чорабинии мазкур қулай аст. Барои муоинаи пардаи зулолӣ, тағояки бандҳо, сатҳи болоии _менискҳо, пайвандҳои пеш ва қафои салибшакл дастрасанд. Ҳангоми синовити музмин ғафсшавӣ ва гиперемияи пардаи зулолӣ мушоҳида гардида, пашмакҳо шаффофияти худро аз даст медиҳанд ва андозаашон калон мешавад. Гоҳо дар сатҳи бандҳо лахтаҳои озодона хобида ё дар пардаи зулолӣ тақарурёфтаи фибрин ба назар мерасад.

Ба ғайр аз муоинаи бандҳо ҳангоми гузарондани артроскопия имконияти иҷро намудани биопсияи бофтаи бандҳо бо тадқиқоти минбаъдаи морфологӣ имкон дорад. Ҳангоми тадқиқи микроскопии маводи гирифташуда дар як қатор ҳолатҳо идентификатсия намудани омили этиологӣ (хламидия, микоплазма, уреоплазма), ҳангоми истифодаи усулҳои иммунофлюоресцентӣ бошад – маводи антигении ба

таркиби маҷмӯи масунӣ дохилшаванда муяссар мегардад.

Қайд кардан лозим аст, ки артроскопия на фақат ба мақсади ташҳисӣ, балки муолиҷавӣ ҳам истифода бурда шуда метавонад. Масалан, шустани бандҳо бо маҳлули изотонии хлориди натрий бо минбаъд таодхул намудани дипроспан барои ба даст овардани хеле паст намудани фаъолнокии раванди ҷуъии илтиҳобӣ имконият медиҳад.

Дар як қатор ҳолатҳо дар ташҳиси ГБР ректоромано- ё фиброколоноскопия нақши муҳим мебозад. Масалан, дар аксари беморони гирифтори ГБР-и баъдиэнтероколитӣ аломатҳои газакгирии рӯда ташҳис карда мешаванд, манзараи гистологӣ бошад дар бораи мавҷудияти илтиҳоби шадид ё музмин шаҳодат медиҳад.

Ба раванд даровардани натиҷаҳои усулҳои клиникӣ, лабораторӣ ва инструменталии тадқиқот барои таҳия намудани меъёрҳои зерини ташҳисии газакгирии бандҳои реактивӣ имконият медиҳад:

- инкишофи беморӣ бештар дар одамони синну соли ҷавон (25-40 сола) мушоҳида мегардад;
- инкишофи нисбатан бештари ГБР дар мардҳо (таносуби мардҳо-занҳо=20:5), ҳол он ки синдроми Рейтер амалан бо басомади якхела (таносуби мардҳо-занҳо=1:1) дучор мегардад;
- алоқаи хронологии беморӣ бо сироятҳои урогениталӣ ё энтероколитӣ (ҳангоми ё баъди 2-6 ҳафтаи пас аз зоҳиршавии аломатҳои аввалини клиникӣ он);
- газакгирии банди бесирояти номутаносиби навъи «нардбонмонанд» бо ғолибан мавзёгирӣ дар бандҳои

пойҳо ва тез-тез ба раванд ҷалбшавии дастгоҳӣ пайӣ-пайвандӣ ва кисаи зулолӣ [бурс] (илтиҳоби пайу кисаи зулолӣ [ахиллобурсит], бурсити зери кафи по ва ғайра);

- зоҳиршавии хориҷибандӣ – кератодермия, раванди қулоъ (афтоз) дар ҳуфраи даҳон, илтиҳоби ҳашафа (баланит), илтиҳоби ҳашфаву қулфа (баланопостит) ва ғайра хос аст;
- серонегативият (дар зардоби хун набудани омили тарбодмонанд);
- ҳамбастагии бештари беморӣ бо дар беморон мавҷуд будани антигени HLA-B27;
- тез-тез ба раванди касолатӣ ҷалбшавии мафсилаи тихигоҳу чорбанд ва сутунмӯҳра;
- бо ёрии усулҳои бактериологӣ, серологӣ ва иммунологӣ ошкор намудани микроорганизмҳои сабабӣ ё антигенҳои онҳо.

ТАШХИСИ ТАФРИҚАНОКИ ГАЗАКГИРИИ БАНДИ РЕАКТИВӢ

Бо гурӯҳи артритҳои сироятӣ, инчунин артритҳои тарбодмонанд, шукуфагӣ (псориазӣ), никрисӣ, спондилогазакгирии банди шаҳаккунанда, бемории Бехчет, артрози шаклвайронкунанда гузаронда мешавад.

Газакгирии банди гонококӣ назар ба мардон дар занҳо бештар дучор мегардад. Ҷараёни беморӣ шадид

бартарафшавии лордози миён, аломатҳои мусбии Кушелевский, Форесте, Шабер, Томайер ошкор карда мешаванд. Ба таври рентгенологӣ нишонаҳои касроилеити дутарафа, спондилит, «квадратнокшавии» мӯҳраҳо муайян карда шуда, сутунмӯҳра шакли «чӯби бамбук»-ро мегирад. Ба таври клиникӣ ташаккули «ҳолати талбанда» ба вучуд меояд. Мушкилоти ташхисӣ ба вучуд меояд, агар дар заминаи беморӣ дардҳо дар банди пойҳо, энтезопатия инкишоф ёфта, дар хун бошад антигени HLA-B27 муайян карда мешавад. Манзараи ҳоси клиникӣ ва рентгенологӣ, тести манфӣ ба хламидия ва дигар барангезандаҳои сироятҳои урогениталӣ ва энтероколитӣ барои ташхис намудани бемории Бехтерев имконият медиҳанд.

Барои бемории Бехчет ярашавии хуруҷкунандаи қулоъии (афтозии) ҳуфраи даҳон, касолати чашмҳо (увеити пеш ва қафо), синдроми бандҳо аз рӯи навъи моно- ва олигоартрит бо ғолибан касолатёбии бандҳои калони дасту пойҳо (артрит, одатан ғайриэрозиявӣ), падидаҳои гуногуни пӯст (эритемаи укдадор, доначасорӣи популезӣ ва/ё пустулезӣ ва ғайра), ихтилолҳои асабия, суддати варидҳои сатҳӣ ва чуқури дасту пойҳо хос мебошад. Дар беморони HLA-B27-позитивӣ гоҳо сакроилеит ташхис карда мешавад. Ҳангоми гузарондани ташхиси тафриканок байни ГБР ва бемории Бехчет ба назар гирифтаи зарур аст, ки ҳангоми бемории Бехчет *решҳои* луобпардаи даҳон ва узвҳои таносул хеле дардноканд ва дар давоми сол чандин маротиба хуруҷ мекунанд, ҳол он ки ҳангоми ГБР онҳо дарднок нестанд. Характери касолати чашмҳо низ гуногун аст: ҳангоми ГБР – ин илтиҳоби мултаҳима (конъюнктивит), ҳангоми бемории Бехчет бошад – увеит мебошад. Маълумотҳои анамнезӣ (сирояти аз сар гузарондашудаи роҳҳои пешоб ё рӯдаҳо дар давоми 2-4 ҳафтаи то пайдо шудани аломатҳои аввалини газаки бандҳо) ба ғоидаи газакирии банди реактивӣ шаҳодат медиҳанд. Меъёрҳои тафрикӣ-ташхисӣ байни ГБР, газаки бандҳои тарбодмонанд ва артрози шаклвайронкунанда дар таблитсаи 2 нишон

дода шудаанд:

Таблитсаи 2

Тавсифи клиникию лаборатории газакгии бандҳои реактивӣ, тарбодӣ ва артрози шаклвайронкунанда

Нишона	Газакгии банди реактивӣ	Тарбод	Артрози шакл-вайронкунанда
Дарди бандҳо дар марҳилаи шадид	Пуршиддат	Пуршиддат	Муътадил
Беҳаракатии пагоҳирӯзӣ	Муътадил	Мавҷуд нест	Пуршиддат
Дардҳои саршаванда	Мавҷуд нест	Мавҷуд нест	Зохиршаванда
Аломатҳои илтиҳоби бандҳо	Дар марҳилаи шадид зохир мешаванд	Дар марҳилаи шадид зохир мешаванд	Зохир намешаванд
Серҳаракатии бандҳо	Маҳдуд аст	Дар марҳилаи шадид маҳдуд аст	Дар дараҷаи меъёр ё маҳдуд
Касолати дил	Миокардио-дистрофия	Ревмокардит ё нуксонҳои дил	Мавҷуд нест
Рентгенографияи бандҳо	Васеъ шудани роғи бандҳо, омоси бофтаҳои назди-бандҳо; перистит, тағйиротҳои эрозиявӣ хангоми ҷараёни музмин	Тағйиротҳо нестанд	Тангшавии роғи бандҳо, экзостозҳо
СТЭ	Баланд аст	Дар марҳилаи шадид баланд аст	Дар дараҷаи меъёр
Гиперглобулинемия	Хос аст	Фақат дар марҳилаи шадид	Мавҷуд нест
Титри АСЛ-0, АСЛ-8	Камтар аз 1:250	Зиёдтар аз 1:250	Дар дараҷаи меъёр
Антигени HLA B27	Ошқор карда мешавад	Мавҷуд нест	Мавҷуд нест
Самара аз истифодаи салитсилаҳо	Суст зохир шудааст	Хуб	Мавҷуд нест

ТАҲИЯИ ТАШҲИСИ ГАЗАКГИИ БАНДИ РЕАКТИВӢ

Таҳияи таҳминии таҳҳис:

1) Газакгии банди реактивӣ.

баъдиэнтероколитӣ, бо касолати бандҳои соку панҷаи по, фаъолнокии дараҷаи II, НФБ (норасогии функсияи бугумҳо)-I;

2) Газакирии банди реактивӣ, пайдоишаш хламидиявӣ бо касолати бандҳои хурди попанҷа ва банди рости соку панҷаи по, фаъолнокии дараҷаи II, НФБ - II;

3) Газакирии банди реактивӣ, пайдоишаш хламидиявӣ бо падидаҳои системавӣ (вараҷа, камхунӣ, лимфоаденопатия, фаъолнокии дараҷаи II, НФБ - II.

МУОЛИҶАИ ГАЗАКИРИИ БАНДИ РЕАКТИВӢ.

Табобати маҷмуии ГБР истифодаи воситаҳои зиддибактериявӣ, доруҳои нестероидӣ, зиддиинтиҳобӣ ва заминавӣ, глюкокортикоидҳо, инчунин як қатор усулҳои иловагии терапевтиро дар бар мегирад, ки бо ҳамбастагҳои гуногун вобаста ба фаъолнокӣ ва характери ҷараёнебии беморӣ таъин карда мешаванд.

ТАБОБАТИ ЗИДДИБАКТЕРИЯВӢ.

Табобати зиддибактериявӣ барои беморони гирифтори ГБР вобаста ба омили этиологӣ (сирояти азсаргузарондаи рӯдагӣ ё урогениталӣ) бо назардошти ҳассосият ба доруҳои зиддибактериявии микроорганизмҳои ҷудонамуда таъин карда мешавад. Ҳангоми иерсиниоз нисбатан бештар тетрациклин бо меъёри 0,8 г/шабонарӯз, гентамитсин бо меъёри 0,16-0,24 г/шабонарӯз ва левомитсетин бо меъёри 2 г/шабонарӯз истифода бурда мешаванд. Ҳангоми шигеллез левомитсетин, доруҳои сулфаниламидӣ ва нитрофуранӣ, ҳангоми салмонеллез бошад – левомитсетин истифода бурда мешавад. Қайд кардан зарур аст, ки ҳангоми муолиҷа бо левомитсетин назорати доимии нишондиҳандаҳои хун зарур аст, зеро дар заминаи истеъмоли дору дар беморон метавонад лейкопения инкишоф ёбад. Даври табобатии зиддибактериявӣ қатъиян фардӣ буда, аз ду то чор

Бо назардошти марҳилаи кутӯхи нимтаҷзияи IgA (қариб 6 рӯз) дараҷаи онро муайян карда, инъикоси мувофиқи раванди ҷорин сироятиро ҳосил намудан мумкин аст. Ҳангоми табобати мувофиқи зиддибактериявӣ титри IgA аллакай баъди 1-2 ҳафта хеле паст мешавад. Ҳангоми такроран сироятнокшавӣ дараҷаи антителаҳо аз сари нав баланд мегардад. Агар баъди муолиҷа титрҳои IgA ва IgG паст нашаванд, пас ин дар бораи шакли музмини (нуфузкунандаи) сироят шаҳодат медиҳад.

ДОРУҲОИ НЕСТЕРОИДИИ ЗИДДИИЛТИҲОБӢ

Барои фуру нишондани фаъолнокии илтиҳобии ГБР доруҳои нестерондии зиддиилтиҳобӣ (ДНЗИ) таъин карда мешаванд, ки як қатор хусусиятҳои умумӣ доранд: ҳос набудани таъсироти зиддиилтиҳобӣ, яъне бозистии аксуламал новобаста аз хусусиятҳои этнологӣ ва нозологӣ; ҳамбастагии таъсироти зиддиилтиҳобӣ, бедардкунанда ва табпасткунанда, таҳаммулпазирии нисбатан ҳуб. Механизми таъсири ДНЗИ бо фуру нишондани синтези простагландинҳо, кининҳо, радикалҳои фаъоли оксиген ва дигар медиаторҳои зиддиилтиҳобӣ, фуру нишондани адгезияи нейтрофилҳо нисбат ба эндотелия аз ҳисоби паст намудани экспрессияи молекулаҳои адгезиявӣ (аз ҷумла, L-селектин) алоқманд аст, ки боиси паст шудани падидаҳои тараққӣи илтиҳобӣ мегардад. Солҳои охир исбот карда шудааст, ки ДНЗИ ҳамчунин қобилияти паст намудани вайроншавии сохтори (деструксияи) бофтаҳо аз ҳисоби бозистити афзонии ҳуҷайраҳоро дорад.

Таснифоти қорини ДНЗИ-ро, ки ҳоло истифода бурда мешавад, меоварем (таблитсаи 4)

Таснифоти ДНЗИ

Ингибаторҳои селективии СОГ-1:

вояи пасти кислотаи атсетилсалитсилонӣ.

Ингибаторҳои ғайриселективии СОГ-1 ва СОГ-

2:

- ҳосилаҳои кислотаи антрапиловӣ (фенамитҳо);
- ҳосилаҳои кислотаи арилалканонӣ (арикулуксӯй, арилпропионӣ, гетероарилуксӯй, икдолуксӯй);
- ҳосилаҳои кислотаи энилоколовӣ (пиразолидиадионҳо, оксикамҳо);
- ҳосилаҳои ғайрикислотагӣ (проквазон, эпипразол, колхсин).

Ингибаторҳои бартаридоштаи СОГ-2:

- мовалис (мелоксикам);
- нимесулид;
- селебрекс

Ингибаторҳои ҳоси СОГ-3:

- венокс

Ҷамаи ДНЗИ-ҳои то имрӯз маълум аз рӯи хусусиятҳои фармакологӣ ва механизмҳои таъсир ба ҳам монанданд. Таъсири зиддиқоғизии онҳо бо фуру нишондани сиклооксигеназа (СОГ) – ферменти асосии мубодилаи кислотаи арахидонӣ, ки ҳангоми туршшавии он простагландин F₂ (ПГ F₂ индикатори асосии таъйиротҳои илтиҳобӣ бандҳо ҳангоми ГБР алоқмаанд менамоянд. Ҳоло 2 шакли ферменти сиклооксигеназа маълум аст. Дар бофтаҳои СОГ-1 мавҷуд аст, ки дар шароитҳои физиологӣ синтез мешавад ва синтези простагландинҳо ба танзим мебарорад, аз осебҳои луобпардаи рӯи меъдаву рӯда ва гурдаҳо муҳофизат менамояд. Ҳангоми СОГ-2 дар бофтаҳои ҳангоми меъра хеле паст аст, вале вай ҳангоми равандҳои илтиҳобӣ бо таъсири моддаҳои фаъоли биологӣ (ситокинҳо, эндотоксинҳо, митогенҳо

хафтаро дар бар мегирад. Одатан ҳангоми табобати дуру дарози зиддибактериявӣ доруҳои зиддизамбуруғӣ (нистатин, дифлюкан, низорал, амфотеритсин В ва ғайра), инчунин доруҳои муътадилкунандаи микрофлораи рӯдаҳо (хилакфорте, линекс, бактисубтил ва ғайра) таъин карда мешаванд.

Ҳангоми молиҷаи ГБР-и урогениталӣ (пайдоишашон хламидиявӣ, уГБРплазмавӣ ва микоплазмавӣ) антибиотикҳои қатори тетрациклинӣ истифода бурда мешаванд: тетрациклин бо меъёри 2 г/шабонарӯз, метатсиклин (рондомитсин) бо меъёри 0,16-1,2 г/шабонарӯз, докситсиклин (вибрамитсин) бо меъёри 0,2 г/шабонарӯз. Аз гурӯҳи макролидҳо, эритромитсин, эритрон, эригексал бо вояи шабонарӯзии 1.5-2.0 г. самарабахшанд. Даври табобатӣ дуру дароз Буда, дар баъзе ҳолатҳо 30-40 рӯзро ташкил медиҳад, зеро даврҳои табобатии 10-15 рӯзаи зиддибактериявӣ камтаъсир ҳастанд ва ба ҷараёни тӯлқашандан беморӣ мусоидат менамоянд. Таъсири иловагӣ тез-тез дучоршаванда ҳангоми истифодаи докситсиклин ва тетрациклин дилбеҳузурӣ, қайдкунӣ, набудани иштиҳо, падидаҳои ҳалалёбии ҳозима, инчунин инкишофи кандидоз ва дисбактериозии рӯдаҳо мебошанд.

Ҳангоми муолиҷаи сироятӣ хламидиявӣ интиҳоб- намудани воситаҳои самарабахши зиддибактериявӣ бо таъсири интиҳобӣ ва таъсири минималии иловагӣ муҳим аст. Солҳои охир барои муолиҷаи ГБР-и урогениталии пайдоишашон хламидиявӣ ба таври васеъ доруҳои зиддибактериявӣ гурӯҳи азалидҳо (макролидҳо): азитромитсин (сумамед) бо меъёри 0,25-0,5 г/шабонарӯз, кларитромитсин (клатсид) бо меъёри 0,5 г/шабонарӯз; вилпрафен бо меъёри 5,0-1,5 г/шабонарӯз, инчунин ҳосилаҳои фторхинолонҳо: офлоксатсин (таривид) бо меъёри 0,4 г/шабонарӯз, спрофлоксатсин (сипробай, сипринол, далатсин Ц) бо меъёри 1,5 г/шабонарӯз, абактал бо меъёри 0,8 г/шабонарӯз истифода бурда мешаванд.

Қайд кардан муҳим аст, ки хламидий

барангезандаи дохилихучайравӣ мебошад, аз ин сабаб хангоми муолиҷаи ГБР-и пайдоишаш хламидиявӣ антибиотикҳои қатори пенитсиллин ва сефалоспоринро истифода бурдан мумкин нест, ки ба дохили хучайра ворид намегарданд. Истифодаи онҳо метавонад барои интиқоли хламидин ба L-шаклҳо (протопластҳо) мусоидат намояд, ки ба табобати зиддибактериявӣ хеле устуворанд ва яке аз сабабҳои қараёни музмини ин сироят мебошанд. Дар баробари ин қараёни тақорёбандаи ГБР-и урогениталӣ метавонад бо сироятнокшавии тақории бемор асоснок шуда бошад, таъин намудани даври табобатии зиддибактериявӣ ва нишондиҳандаҳои ҷинсӣ ҳатмӣ мебошанд.

Барои муайян намудани самаранокии табобати зиддибактериявӣ хангоми мавҷуд будани сирояти хламидиявӣ ба маркерҳои серологӣ (зардобӣ) ва аз ҷумла ба ғуншавии IgA-и махсус эътино намудан муҳим аст (таблитсаи 3).

Таблитсаи 3.

Маркерҳои зардобӣ хангоми сирояти хламидиявӣ

Марҳила		Синфи ИММУНОГЛОБУЛИНҲО	
		LgG	LgA
Шадиди хламидиявӣ	+	-/+	-/+
ХЛАМИДИОЗ И музмин	-	+/-	+/-
Шифоёбӣ	-	4 маротиба пастшавии титр баъди 1- 1,5 моҳи пас аз муолиҷа	2-4 маротиба пастшавии титр баъди 5 рӯзи пас аз табобати комплан мувофиқ

ва гайра) якбора баланд мешавад. Дар ин маврид СОГ-2 мавкеи мухимро дар синтези простагландинҳо мебозад, ки аксуламалҳои илтиҳобии ҷузъӣ ва ҳам умумиро (баландшавии ҳарорат, ташаккули омосҳо, мутамарказонидани дардҳо, ихтилоли функсия ва гайра) барангезиш медиҳад ва нигоҳ медорад.

Самаранокҳои доруҳои гуруҳҳои гуногун якхела нест, аз ин сабаб басомдаи таъин намудани ин ё он воситаи фармакологӣ гуногун аст. Аз ҷумла, салитсилатҳо (аспирин) хангоми муолиҷаи беморони гирифтори ГБР паҳншавии васеъ наёфтанд. Нисбатан бештар ингибиторҳои гайриселективии сиклооксигеназа истифода бурда мешаванд, ки дар зер оварда шудаанд.

Ҳосилаҳои кислотаи арилуксусӣ – *диклофенак* (курсҳо, ғилофак, шамъчаҳо *0,025, 0,05 ва 0,1 г., ампулаҳо бо меъёри 3 мл, ки 0,05 г моддаи ғайроқандор, вояи шабонарӯзӣ то 1 г); *ортофен* (курсҳо бо меъёри 0,025 г, ампулаҳо бо меъёри 3 мл, ки 0,075 г моддаи ғайроқандор).

Ҳосилаҳои кислотаи пропионовӣ – *ибупрофен* (курсҳо ва ғилофакҳо бо меъёри 0,025 ба 0,05 г, вояи шабонарӯзона то 3 г); *напроксен* (курсҳо, шамъҳо бо меъёри 0,25 г, вояи шабонарӯзона то 1 г); *кетопрофен* (курсҳо бо меъёри 0,05 г, вояи шабонарӯзона то 0,3 г); *флурбипрофен* (курсҳо, шамъҳо бо меъёри 0,05 ва 0,1 г, вояи шабонарӯзона то 0,4 г); *кислотаи тиапрофеновӣ* (ғилофакҳо бо меъёри 0,2 ва 0,3 г, вояи шабонарӯзона то 1,2 г).

Ҳосилаҳои кислотаи индолуксусӣ – *силиндак* (курсҳо бо меъёри 0,15 г, вояи шабонарӯзона то 0,3 г); *индометатсин* (курсҳо, ғилофакҳо бо меъёри 0,025 г, вояи шабонарӯзона то 0,2 г).

Пиразолидиндионҳо *клофезол* (ғилофакҳо бо меъёри 0,2 г, вояи шабонарӯзона то 1,2 г); *фенилбутазон* (курсҳо бо меъёри 0,15 г, вояи шабонарӯзона то 0,6 г).

Оксикамҳо – *пироксикам* (курсҳо, ғилофакҳо бо меъёри 0,01 ва 0,02 г, вояи шабонарӯзона то 0,04 г);

теноксиком (ғилофакҳо бо меъёри 20 мкг); селебрекс (Pfizer) (ғилофакҳо бо меъёри 200 мг ва 100 мг, меъёри шабонарӯзӣ то 400 мг).

Доруҳои омехта: артротек (диклофенак 0,05 + мизопростол 200 мкг дар 1 курс).

Маълум аст, ки таъсири зиддиилтиҳобӣ ва зиддидардии қисми зиёди ДНЗИ-ҳо тавассути фуру нишондани маҳсули ду изоформҳои СОГ бо минбаъд пастшавии синтези простагландинҳо амалӣ мегардад, таъсироти иловагӣ инкишофёбандаи РМР ва гурдаҳо бо паст намудани фаъолияти СОГ-1 асоснок гардидааст. Аз ин сабаб самти самарабахши табобати ГБР нисбатан васеъ истифода бурда шудани ингибиторҳои бартаридоштаи СОГ-2 мебошад, ки яке аз онҳо селебрекс мебошад.

Мовалис таъсири пурзӯри тез таъсиркунандаи аналгетикӣ, зиддиомосӣ ва зиддиилтиҳобӣ бо фаъолнокии минималии ултсерогенӣ дорад. Дору синтези ферментҳои бофтаҳои вайронкунандаи тағоякиро (коллагеназаҳо, эластазаҳо ва ғайра) боз медоранд, на фақат боиси кам шудани осебҳои матрикси тағоякӣ, балки муътадил шудани равандҳои синтези бофтаҳои тағояк мегардад. Таъсири муолиҷӣ (терапевтӣ) ҳамчунин бо таъсири он ба як қатор омилҳои дигар асоснок шудааст: фуру нишондани коркарди омили фаъолнокии тромботситҳо, ситокинҳои зиддиилтиҳобӣ, протеиназа, гистамин ва ғайра.

Барои селебрекс дараҷаи баланди алоқамандшавӣ бо сафедаҳо (99%) ва биодастрасии баланд (90%) ҳос аст. Вай тез ба моеи зулолӣ ворид гашта, дар он ҷо гуншавии мувофиқи терапевтии моддаи фаъолро ҳосил менамояд. Дар ин маврид дар натиҷаи паст намудани фаъолияти селективии СОГ-2 дору назар ба дигар ДНЗИ камтар аст, таъсироти иловагӣ ба роҳҳои меъдаву рӯдаро нисбати гурдаҳо дорад, ба мисли ҳосилшавии решҳо, шикӯшавӣ ва хунравӣ, инчунин бо захрогинии нисбатан паст фарқ мекунад.

Марҳилаи нимхориҷшавии селебрекс 22 соатро нишон медиҳад, ки барои як бор дар як шабонарӯз истеъмоли намудани он имконияти медиҳад. Ғуншавии доимии хун дар зардобии хун баъди 3-5 рӯзи доимо қабули намудан ба даст оварда мешавад. Таъсири байниҳамдигарии аз ҷиҳати клиникӣ аҳамиятнокӣ селебрекс ба гизо ва доруҳо (антасидҳо, гликозидҳои дил, H_2 -блокаторҳо, антикоагулянтҳои ғайримустақим ва ғайра) ошкор карда нашудааст. Дар одамони кӯҳансол давраи нимҳаётии дору каме боло меравад, ки босии зиёдшавии басомади аксуламалҳои захрогинӣ мегардад.

Ҳоло санҷишҳои бешумори клиникӣ бо назорати дутарафи ниҳонӣ ба анҷом расидаанд, ки дар онҳо даҳҳо ҳазор беморони гирифтори артритҳои илтиҳобӣ иштирок намуданд. Ба таври муътамад муқаррар карда шудааст, ки селебрекс бо вояи 100-200 мг бо самаранокии диклофенак ва пироксикам муқоисашаванда аст, вале аз ҷиҳати таҳаммулпазирӣ аз онҳо болотар меистанд. Ба ҳамин тариқ, ҳатари касолати луобии роҳи меъдаву рӯда дар заминаи муолиҷа бо селебрекс (200 мг/шабонарӯз) назар ба истифодаи диклофенаретард ва пироксикам якҷанд маротиба камтар аст (таблитсаи 5)

Таблитсаи 5
Иқтидори зиддиилтиҳобӣ ва ултсерогении селебрекс дар муқоиса бо дигар ДНЗИ

ДНЗИ	Газакгии банди адовангӣ ID (мг/шабонарӯз)	Заҳмиҳои меъда ED (мг/кг/шабонарӯз)	Таносуби заҳм/артрит
Селебрекс	0,12	2,42	20
Диклофенак	1,23	2,71	2,2
Пиооксикам	0,77	1,09	1,4
Напроксен	11,8	11,2	0,95
Аспирин	19,8	32,4	0,16

Вояи терапевтии (муолиҷии) селебрекс аз фаъолнокии ГБР ва мавҷуд будани бемориҳои ҳамроҳикунанда вобаста аст ва 100-200 мг дар як рӯзро

ташкил медиҳад.

Бехтараш вояи нисбатан пасти нигоҳдорандаеро истифода бурдан лозим аст, ки самараи бехтари муолиҷиро таъмин менамояд. Гилофакҳо ба таври бутун бо микдори начандони зиёди моеъ хангоми хӯрокхӯрӣ як бор дар як шабонарӯз истеъмол карда мешаванд. Селебрекс ҳамчун доруи интиҳобӣ хангоми табобати дуру дарози ГБР, инчунин барои беморони гирифтори бемориҳои роҳи меъдаву рӯда тавсия дода мешавад.

Таҷрибаи чандинсолаи клиникӣ нишон дод, ки интиҳоби ин ё он ДНЗИ барои ҳар як бемор одатан ба таври эмпирикӣ бо роҳи мунтазам интиҳоб намудани дору хангоми самаранок набудани доруи пешина ба амал меояд. Духтур аз рӯи инкишофи (динамикаи) эҳсосоти дард дар бандҳо муддати 7-10 рӯз ба самараи зиддиинтиҳоби ва зиддидардӣ доруи истифодашаванда баҳо медиҳад. Дар ҳолати набудани самараи мусбат ДНЗИ бояд бо дигараш иваз карда шавад, ки метавонад намояндаи худӣ ҳамон гурӯҳи химиявӣ бошад.

Чандкаррати қабули ДНЗИ аз давраи нимхориҷшавии онҳо вобаста аст. Доруҳои дорои марҳилаи кӯтоҳи ихроҷ (1-8 соат) 3-4 маротиба дар як шабонарӯз (ибупрофен, индометатсин, диклофенак, кетопрофен), бо давомнокии миёнаи марҳилаи нимхориҷшавӣ (10-20 соат) – 2 маротиба дар як шабонарӯз (напроксенсулиндак), бо марҳилаи нисбатан дуру дарози нимхориҷшавӣ (пироксикам, мелоксикам, фенилбутазон) – 1 бор дар як шабонарӯз таъин карда мешаванд. Ҳамзамон таъин намудани доруҳои гурӯҳҳои гуногун на фақат мувофиқи мақсад нест, балки зараровар аст, зеро ки самаранокии таъсири зиддиинтиҳобӣ баланд намегардад, басомади инкишофи таъсири иловагӣ бошад якбора баланд мешавад.

Оризаи нисбатан бештар дучоршаванда хангоми дуру дароз истеъмол намудани ДНЗИ – бо ном «ДНЗИ-гастропатия» мебошад, ки бо ихтилолҳои ҳозимавӣ (диспепсия), касолати луобпардаи меъда ва

рӯдаи дувоздахангушта зоҳир мегардад. Он дар натиҷаи бозистии синтези простагландинҳо ба вучуд меояд, ки таъсири физиологии ситопротективӣ дорад. Омилҳои асосии хатари инкишофи «ДНЗИ-гастропатия» солхӯрдагии беморон, дар собикаи беморӣ (анамнез) мавҷуд будани решмараз, хунравиҳои меъдаву рӯда ё ҳамбастагии табобати ДНЗИ ва глюкокортикоидҳо, дуру дароз муолиҷа намудан бо вояҳои баландит ДНЗИ ё ҳамзамон қабул намудани 2-3 доруи ин гурӯҳ мебошанд.

Баҳои муқоисавии ғаълҳои уотсерогении ДНЗИ-и гуногун нишон дод, ки аз ҳама шадид кислотаи атсетилсалитсилавӣ ва напроксен, нисбатан шадиднокии камтар – салитсилатҳои ғайриатсетилӣ, доруҳои кислотаи пропионӣ (ибупрофен, флурбипрофен), баъзе аз ҳосилаҳо – кислотаи индолкусусӣ (султендак, этодолак), инчунин ҳосилаҳои кислотаи энолиевӣ – мелоксикам (мовалис) мебошанд; Дар ин қатор мавқеи миёнаро диклофенаки натрий, индометасин ва кетопрофен ишғол мекунанд.

Барои профилактика ва муолиҷаи «ДНЗИ-гастропатия» тамоми маҷмӯи воситаҳои зиддирахмӣ истифода бурда мешаванд: блокаторҳои H₂, ретсепторҳои гистаминӣ: омепрозол, Вентер; антасидҳо, мушобеҳи синтетикии ПГ-Е – мизопрастол истифода бурда мешаванд. Ғайр аз ин, таъин намудани доруҳои омехта (артротек, ки дорои диклофенаки натрий ва мизопрастол мебошад), ДНЗИ-и бо пӯшиши дар рӯда ҳалшаванда (салисалат), инчунин блокаторҳои самаранокиашон баланди СОГ-2 (селебрекс) тавсия дода мешавад.

Аз дигар таъсироти иловагии ДНЗИ касолати гурдаҳо дар амсилаи (варианти) нефрити шадиди интерститсиалӣ имконпазир аст, ки бо вараҷа, эозинофилия ва синдроми пешоб, системаи марказии асаб (дар беморон дарди сар, сархчархзанӣ, галлютсинатсия, депрессия, ҳалалёбии хотира, ҳоболудӣ), чигар (гепатити доругӣ), пӯст (крапивница, эритемаи укладор, фотосенсибилизатсия ва ғайра),

хамчунин инкишофи ихтилолҳои гематологӣ (лейкопения, агранулоцитоз, камхунии пластитикӣ, пастшавии хусусиятҳои агрегатсионии тромбоцитҳо) зоҳир мегардад. Бо назардошти инкишофи чунин номгӯи зиёди таъсири иловагӣ назорати дақиқи духтур аз болои беморон ҳангоми дуру дароз истифода бурдани ДНЗИ зарур аст.

ДОРУҲОИ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДӢ

Ҳангоми ғаълонокии баланди ГБР, инчунин самаранокии нокифояи ДНЗИ барои беморон таъин намудани доруҳои глюкокортикоидӣ (ГКС) нишон дода шудааст. Таъсири зоҳиршавандаи зиддиилтиҳобии ГКС бо қобилияти пешгирӣ намудани муҳочирати лейкоцитҳо ба минтақаи илтиҳоб аз ҳисоби фуру нишондани экспрессияи молекулаҳои адгезионӣ (ELAM-1 ва ICAM-1) бо ҳуҷайраҳои эпителиалӣ ва транскрипсияи генҳои ситокинҳои қабиллиилтиҳобӣ (IL-1b, FНО-а, IL-8 ва ғайра); барангезиш додани синтези липокортин – ингибитори ғаълонокии фосфолипазаи А; фуру нишондани ғаълонокии СОГ-2, инчунин паст намудани экспрессияи генҳои металлопротеиназа алоқаманд карда мешавад. Таъин намудани ГКС боиси кам шудани нифозати гишои биологӣ, аз ҷумла лизосималӣ мегардад, ки ба аз ҳуҷайраҳо хоричшавии ферментҳои протеолитӣ ва ба ин васила ба якбора паст шудани зоҳиршавии падидаҳои илтиҳобӣ дар бандҳо монеа мешавад.

Вояи преднизолон аз ғаълонокии беморӣ вобаста аст ва 30-60 мг-шабонаруз, селестон – 206 мг/шабонарузро ташкил медиҳад. Ҳангоми ихтилоли роҳи меъдаву рӯда доруҳои глюкокортикоидӣ ба доихли мушак ворид карда мешаванд. Баъди ба даст омадани самарайи муолиҷӣ (терапевтӣ) вояи дору

тадричан то пурра барҳам додани он паст карда мешавад. Ҳангоми зарурият глюкостероидҳо ба таври доихили бандҳо ё атрофии мушакҳои бандҳо ворид карда мешаванд (1-2 тазриқи дипроспан бо фосилаи 10-15 рӯз).

Барои ба даст овардани иммуносупрессия ҳангоми фаъолнокии баланди ГБР «набз-табобат» истифода бурда мешавад, ки ба бемор 1000 мг метилпреднизолон (метипред) ба таври дохиливоридӣ қатрагӣ дар 150 мл маҳлули изотонии хлориди натрий дар муддати 40-45 дақиқа се рӯз пайдарҳам тадохул карда мешавад. Ҳоло мувофиқи мақсад будани истифодаи вояҳои камтари дору – тадохули секаратаи 500 мг метилпреднизолон (табобати «мини-набз») асоснок карда шудааст.

Ҳангоми ба беморони ГБР таъин намудани вояҳои қомилан мувофиқи преднизолон (селестон) таъсири клиникӣ аллакай дар рӯзи дигари оғозии муолича, ҳангоми тадохули перентералӣ бошад – баъди якчанд соат мушоҳида карда мешавад. Дар баробари ин ҳангоми тез қатъ намудани дору инкишофи «синдроми қатъкунӣ» чой дошта метавонад, ки бо пурзӯршавии дарди бандҳо ва баланд шудани фаъолнокии лаборатории ГБР тавсиф меёбад. Ҳангоми дуру дароз таъин намудани ГКС амалӣ намудани назорати динамики беморон бо иҷро намудани як қатор тадқиқотҳои ҳатмӣ клиникӣ лабораторӣ ва инструменталӣ (назорати фишори шараёнӣ, дараҷаи гликемия, миқдори калтсий дар зардоби хун, гузарондани фиброгастродуоденоскопия ва ғайра) барои ташҳиси саривақтии оризаҳои инкишофёбандаи табобати гормоналӣ зарур аст.

ВОСИТАҲОИ ЗАМИНАВӢ

Ҳангоми фаъолнокии дуру дароз

нигоҳдошташавандаи ГБР, инкишофи касолатҳои системавӣ (вараҷа, камшавии вазни бадан, лимфоаденопатия, камхунӣ ва ғайра), самарабахш набудани муолиҷа, инчунин хангоми ҷараёни музмин ва тез-тез хуруҷкунандаи ГБР ба табобати маҷмӯӣ воситаҳои заминавиरो дохил менамоянд, ки аз гурӯҳи доруҳои аз ҷиҳати химиявӣ гетерогенӣ бо хусусиятҳои умумии таъсири муолиҷӣ иборат буда, бо инкишофи оҳиста-оҳистаи таъсири муолиҷавӣ, инкишофи фурунишонии зоҳиршавандаи падидаҳои клиникӣ ва лаборатории (аз ҷумла масунии) беморӣ ба нигоҳдоштани аломатҳои беҳтаршавӣ (ремиссия) баъди қатъ намудани истифодаи доруҳо тавсиф меёбанд (табл. 6). Самараи муолиҷавии доруҳои заминавӣ на дертар аз 2-3 моҳи пас аз оғози муолиҷа шурӯъ мешавад ва баъди 6-8 моҳи табобати мутассил ба қуллаи баланди худ мерасад.

Доруҳои қатори хинилиновӣ (хлорохин, делагил, плаквенил) аз сабаби самаранокии нокифояи онҳо камтар таъин карда мешавад. Дар баробари ин, онҳо ба беморони гирифтори вариантҳои тӯлкашидаи беморӣ бо ғаълонокии начандон баланд нишон дода шудаанд. Механизми таъсири доруҳо аз бозистиҳои ғаълонокии ҳуҷайраҳои салоҳиятноки масунӣ, муътадилшавии гишоҳои лизсоомалӣ ва фурунишондани аз лисомаҳо хориҷшавии ферментҳои протеолитӣ, алоқмандкунии радикалҳои озод ва кам намудани таъсири ҳаробиовари онҳо ба бофтаи пайвандӣ, боздории фаготситоз ва хемотаксиси нейтрофилҳо ва фурунишондани синтези простагландинҳои қабилитиҳобӣ иборат аст.

Хлорохин (делагил) бо қруҳои 0,25 г ва ампулаҳои 5 мл маҳлули 5%, плаквенил – бо қруҳои 0,25 г бароварда мешавад. Дар 2-4 ҳафтаи авали муолиҷа доруҳо ба миқдори 1 қру 2 бор дар як рӯз

таъин менамоянд, сипас ба табобати дурудароз бо вояи 1 курс шабона, ҳар рӯз дар муддати моҳҳои зиёд мегузаранд. Таъсири ибтидоӣ аз табобат бо таркиби аминотинолиноӣ баъди 3-6 моҳ, таъсири максималӣ бошад – баъди 6-12 моҳи табобати мутасил баҳо дода мешавад.

Таҳаммулпазирии доруҳои ин гурӯҳ умуман хуб аст, вале аксулмалҳои иловагӣ дар шакли падидаҳои ҳозимаӣ (диспепсия), сӯзиши пӯст, сарчарханӣ, лейкопенияи интиқолибанда (назорати доимии миқдори лейкоцитоз дар хуни ноҳиявӣ зарур аст), рентиитҳои пигментӣ, замшавии дору дар қарни (барои сари вақт ошкор намудани тағйироти мазкур машаваратдиҳии духтури чашм як бор дар 3-4 моҳ зарур аст) имкон доранд.

Нисбатан бештар барои муолиҷаи ГБР доруҳои сулфаниламидӣ (*сулфасалазин, салазодин, салазопиридазин, салазодиметоксин*) истифода бурда мешаванд, ки таъсири зиддиинфектибӣ (аз ҳисоби фуру нишондани синтези простагландинҳо ва лейкотриенҳо), зиддибактериявӣ ва иммуносупрессивӣ доранд. Ғайр аз ин, дар таҷқиботи *in vitro* таъсири боздорандаи онҳо ба нумуи ҳуҷайраҳои зулолӣ ва истеҳсоли ИЛ-1b ва ИЛ-6 бо фибробластҳои барангезанда исбот карда шудааст. Сулфасалазин аз конюгати кислотаи 5-аминосалицилатӣ ва сулфапиридин иборат аст. Дар шӯъбаҳои болоии роҳи меъдаву рӯда танҳо 10-30% дору ҷаббида мешавад, дар ин маврид қариб 10% ин миқдор бо пешоб дар шакли тағйирнаёфта хориҷ мегардад. Қисми асосии дору ба рӯдаи ғафс меравад, ки дар он ҷо бо таъсири микрофлораи рӯдаҳо ҷудошавии алоқаи молекулавӣ байни ҷузъҳои асосии молекулаи сулфасалазин ба вучуд омада, сулфапиридин қариб пурра ба рӯда ҷаббида шуда, таъсири муолиҷавӣ мерасонад.

Дар заминаи муолича бо доруҳои сулфаниламидӣ падидаҳои клиникию лаборатории беморӣ кам мешаванд ва суръати шиддатёбии тағйиротҳои шаклвайронкунандаи (деструктиви) бандҳо суст мешавад.

Доруҳо барои марҳилаи дуру дароз пешбинӣ шудаанд, табобат бо сулфаласалазин бо вояи 0,5 г дар як шабонарӯз муддати як ҳафта барои баҳо додан ба таҳаммулпазирӣ оғоз меёбад, списасон 0,5 г дар як ҳафта то вояи максималии 2 г/шабонарӯз зиёд карда мешавад. Ҳангоми ба даст омадани беҳбудии (ремиссияи) клиникию лабораторӣ вояи дору то нигоҳдоранда ва сипас пурра қатъ кардани он кам карда мешавад. Даври табobati минималии муолича бо доруҳои сулфаниламидӣ 3-4 моҳро ташкил медиҳад; ҳангоми набудани самаранокӣ баъди 4-моҳ истеъмоли онҳо мувофиқи мақсад шуморида намешавад ва барои беморон дигар доруи заминавӣ таъин карда мешавад.

Таҳаммулпазирии доруҳои сулфаниламидӣ пурра каноатбахш аст. Ба таъсири иловагӣ дилбеҳузурӣ, дарди шикам, дарди сар, сарчарҳзанӣ, доначасорӣ пӯст, лейко- ва тромбоцитопения, гоҳо – ихтилоли фазла, баланд шудани дараҷаи трансаминаза, стоматит дохил мешаванд. Басомади онҳо метавонад ҳангоми дояҳои нисбатан пасти дору (1-1,5 г дар як шабонарӯз) паст карда шавад. Ғайринишондод барои таъин намудани сулфасалазин таҳаммулнопазирӣ ба сулфаниламидҳо, инчунин аломатҳои ҳалалёбии функсияи чигар ва испурҷ мебошанд.

Ҳангоми вариантҳои музмини ҷараёни ГБР доруҳои ситостатикӣ метотрексат (МТ), азатиоприн (имурин), сиклофосфан ва ғайра самарائي максималии муоличивӣ мерасонанд. Механизми таъсири ситостатикҳо аз боздории аксуламалҳои аутоиммунӣ аз ҳисоби фуру нишондани ҳосилшавӣ ва тарашшӯҳи

ситокинҳо ва алоқманд намудани онҳо бо ретсепторҳои махсус, фуру нишондани нумуи Т-лимфоситҳо (ба дараҷаи зиёд Т-хелперҳои навъи 1) дар натиҷаи фуру нишондани истехсолишавии ИЛ-2 ва омили инкишофи Т-лимфоситҳо, боз доштани ҳосилшавии аутоантителаҳо ва маҷмӯҳои бемориовари масунӣ иборат аст. Таъсири зиддиилтиҳобии доруҳои ситостатикиро бо қобилияти муътадил намудани гишоҳои лизосомалии ҳуҷайравӣ ва боз доштани ихроҷи ферментҳои протеолитӣ ба сатҳи хориҷиҳуҷайравӣ алоқманд менамоянд.

Метотрексат (МТ) антагонисти (мутақобилаи) кислотаи фолиевӣ мебошад, ки барои синтези ДНК ва РНК зарур аст. Баъзе аз самараҳои фармакологии МТ бо таъсири дору ба синтези полиаминҳо вобаста буда метавонад, ки дар раванди нумуи ҳуҷайраҳо ва синтези сафеда, инчунин дар аксуламалҳои ҳуҷайравӣ-бавоситаи масунӣ иштирок мекунад.

Дар заминаи муолиҷа бо вояҳои пасти МТ дар беморон интиқоли синтези ситокинҳо бо Th1 (ИЛ-2, ИФН-γ) ба навъи Tn2 (ИЛ-10) мушоҳида мегардад, ки барои шарҳ додани самарои зоҳиршавандаи зиддиилтиҳобӣ ва иммуномодулирии вояҳои пасти дору имконият медиҳад. Ба наздикӣ маълумотҳо дар бораи он ба даст омаданд, ки *in vitro* МТ тафриқасозии монцитҳо ва экспрессияи Fas-антигенро барангезиш медиҳад, ки бо пурзӯр шудани озодшавии ситокинҳои зиддиилтиҳобӣ (мутақобилаи ҳалшавандаи ИЛ-1β ва РФНО-75P) ҳмабастагӣ менамояд. Яке аз механизмҳои эҳтимолии

Таблитсаи 6

Таъбати заминавии газакгирии бандҳои реактивӣ

Дору	Таъсир	Нишон дод	Вояҳо ва нақшаи муолиҷа	Таъсириро тибқи иловагӣ	Назорати клиникаӣ ва лабораторӣ
Доруҳои катори хилонилловӣ (делагил – курсҳои бо меъёри 0,25 ва ампл. бо меъёри 5 мл маҳлули 5%,	Муътадилшавии гишои лизосо маъл.				
Доруҳои сулфаниламидӣ					

таъсири зиддиилтиҳобии МТ фуру нишондани равандҳои муҳочирати монотситҳо аз мағзи усутхон ба минтақаи илтиҳоб ва паст шудани давомнокии ҳаётии ин ҳуҷайраҳо дар бофтаҳои сармозада мебошад.

Дар тадқиқотҳои сершумор исбот карда шуда буд, ки ҳангоми истифодаи МТ беҳбудии клиникӣ назар ба муолиҷа бо дигар доруҳои заминавӣ, аз ҷумла ситостатикӣ тезтар фаро мерасад ва вобастагии дақиқ аз вояи истеъмолшавандаро дорад. Вояи ибтидоии МТ дар бисёр ҳолатҳо 7,5 мг дар як ҳафтара ташкил медиҳад. Аз сабаби таҳаммулнопазирии яқвақтаи вояҳои калони дору ба таври тақсимшаванда таъин намудани он бо фосилаи 12-соата пағоҳӣ ва бегоҳӣ тавсия дода мешавад. Нақшаи истеъмоли дору чунин аст: рӯзи 1-ум -2,5 мг; рӯзи 2-юм- 2,5 мг 2 бор дар як шабонарӯз бо танаффуси минбаъдаи 5-рӯза. Самараи клиникӣ баъди 4-8 ҳафта баҳо дода мешавад, дар ҳолати набудани он ҳангоми таҳаммулнопазирии муътадил тадриҷан 2,5 мг дар як ҳафтато вояи умумии 12,5 мг дар як ҳафта зиёд карда мешавад. Дар заминаи

муолича бо МТ аз таъин намудани салистилатҳо ва ДХНИ-и таъсирашон кутохмуддат худдорӣ бояд намуд.

Муолича бо МТ-ро дар шароитҳои бистарӣ оғоз менамоянд ва фақат баъди интиҳоб намудани вояи мувофиқи дору табобатро дар шароитҳои амбулаторӣ идома додан мумкин аст. Самаранокии баланди МТ дар беморони гирифтори ГБР бо касолатҳои пӯсту луобӣ исбот карда шудааст. Вақтҳои охир ахборотҳо оид ба истифодаи бомувафақияти МТ дар шакли тазриқи дохилибандӣ дар беморони гирифтори синовит, ки ба глюкокортикоидҳо муқовиматпазир мебшанд, пайдо шуда истодааст.

Бо вучудуи он ки ин ё он падидаҳои иловагӣ дар аксари беморони вояҳои пасти МТ-ро қабулкунанда дида мешавад, умуман таносуби самаранокӣ/заҳрогинии МТ назар ба таъин намудани дигар доруҳои заминавии зиддитарбодӣ беҳтар аст. Дору назар ба дигар доруҳои заминавӣ индекси қатъкунии камтар (зиёда аз 2 маротиба), иқтидори пасти онкогенетикӣ ва доираи васеи вояҳои муоличавиро дорад, ки назорати мувофиқи чараёни беморию таъмин менамояд. Аз аксуламалҳои иловагӣ имконияти инкишофи стоматит, пневмонит, хуруҷи хунравӣ, баланд шудани микдори ферментҳои ҷигар дар хунро қайд кардан лозим аст. Маълумотҳо дар бораи пастшавии мӯътамади басомад ва зохиршавии падидаҳои иловагии муолича бо МТ (ба истиснои ситопения ва касолати шушҳо) ҳангоми таъин намудани кислотаи фолиевӣ бо вояи 5 мг дар як рӯз мавҷуданд.

Ба сифати заминавӣ дигар доруҳои гурӯҳи антиметаболитҳо, аз ҷумла *азатиоприн* (*имуран*) истифода бурда мешавад. Азатиоприн аз ҷиҳати биологӣ фаъол нест, вале дар организм вай ба 6-меркаптопурин табдил меёбад, ки таъсири бевоситаи муоличавӣ мерасонад. Механизми таъсири дору аз фуру нишондинаи синтези ДНК ва РНК ба лмифотситҳои фаъолна нумӯкунанда ва монотситҳо иборат аст, ки дар индуктсияи ва нигоҳ доштани раванди масунию илтиҳобӣ дар беморони гирифтори ГБР аҳамияти асосӣ доранд. Дар тарбодшиносӣ ба таври васеъ истифода бурдани на 6-меркаптопурин, балки азатиоприн бо он алоқманд аст, ки дар хун зиёд шудани ғуншавии азатиоприн тадричан ба вучуд омада, таъсири камтар зохиршавандаи заҳрогинӣ мерасонад.

Азатиоприн бо вояи 350 мг/шабонарӯз (вояи муолиҷавӣ) бо гузаштан ба вояи нигоҳдоранда (100-50 мг/шабонарӯз) ҳангоми ба даст омадани беҳбудии клиникаию лаборатории ГБР таъин карда мешавад. Одатан, ба даст овардани беҳбудӣ ҳангоми шаклҳои музмини ГБР баъди 3-4 моҳи табобати мутассил ба даст меояд. Ҳангоми пурра мавҷуд набудани самара баъди 2,5-5 моҳ истеъмоли дору қатъ карда мешавад.

Сиклофосфан, ки намоёндаи ситостатикҳои алкилӣ мебошад, ҳамчунин доруи интиҳобшаванда дар қатори воситаҳои заминавӣ ҳангоми шаклҳои тўлкашида ва музмини чараёни ГБР мебошад. Баръакси антиметаболитҳо доруҳои алкилӣ на фақат ба ҳуҷайраҳои фаъоли нумукунанда, балки ба ҳуҷайраҳои оромгирифтаи иммунокомпетентӣ таъсир мерасонанд. Бо таъсири сиклофосфан кам шудани массаи бофтаи лимфоидӣ дар организм ба вучуд омада, аксуламалҳои ҳуҷайравӣ ва гуморалии масунӣ фуру менишинанд. Ҳоло нуктаи назаре мавҷуд аст, ки сиклофосфан дар баробари таъсири иммуно-депрессивӣ таъсири зиддиинтиҳобӣ низ мерасонад.

Қайд кардан зарур аст, ки сиклофосфан ба мисли азатиоприн худ аз худ моддаи фаъоли биологӣ намебошад. Бо хуни гардишкунанда ба чигар дохил шуда, вай бо таъсири ситохроми Р₄₅₀ ба метаболитҳои фаъол – фосфамид ва акролеин табдил меёбад, ки ҳам таъсироти ситостатикӣ ва ҳам иммуносупрессивӣ мерасонанд. Дору аз роҳи меъдаву рӯда нағз ҷаббида мешавад, давраи нимҳориҷшавӣ аз плазмаи хун аз 2 то 10 соатро ташкил медиҳад.

Сиклофосфан ба таври парентералӣ (400-600 мг/ҳафта) ё per os бо вояи 100-150 мг/шабонарӯз таъин карда мешавад (шакли курсмонанди дору – *эноксан* истифода бурда мешавад). Ҳангоми фаъолнокии баланди ГБР ва мавҷуд будани падидаҳои системавӣ тадохули якқарратаи дохиливаридии «вояи зарбазанадаи» (1000 мг) сиклофосфан тавсия дода мешавад. Дар ҳолати чараёни кашолёбандаи ГБР бо фаъолнокии баланди иммунологӣ самарани тез ва зохиршаванда ҳангоми таъин намудани «набз-табобати» ҳамбаста (метипред – 1000 мг ба таври доихиливаридии қатрагӣ бо 150 мл маҳлули изотонии хлориди натрий дар муддати 3 рӯз ва 1000 мг сиклофосфан бо 400 мл маҳлули изотонии хлориди

натрий яккаррата дар рӯзи аввали табобат) ба даст оварда мешавад.

Чи хеле ки қайд карда шуд, доруҳои ситостатикӣ таъсири возеҳи иммуносупрессорӣ расонда, ба ин васила назорати мувофиқи ҷараёни ГБР-ро таъмин менамоянд. Вале таъсири дуру дарози иловагӣ мавҷуд аст, ки аз ҳама асосиашон дилбеҳузурӣ, гастралгия, гепатозахрогинӣ, холестаз, тағйир ёфтани таркиби хуни ноҳиявӣ (лейко- ва тробоситопения, агранулоцитоз), паст шудани муковиматпазирии организм ба сироятҳо мебошанд, ки метавонанд боиси инкишофи пневмония, herpes zoster, пиодермия, хуруҷ намудани сарчашмаҳои сирояти музмин ва ғайра гарданд. Ҳангоми истифодаи сиклофосфан инкишофи ситстити геморрагӣ имкон дорад. Пайдо шудани самараҳои захрогинӣ муваққатан қатъ намудани истеъмоли доруро бо минбаъд ислоҳ намудани воя ё таъин намудани дигар воситаи заминавиरो талаб менамояд.

ЭНЗИМОТЕРАПИЯИ СИСТЕМАВӢ

Солҳои охир дар амалияи клиникӣ татбиқи намудани гурӯҳи нави доруҳо самаранокии муолиҷаи ГБР, махсусан шаклҳои тез-тез хуруҷкунандаи музмини бемориро хеле беҳтар намуд. Дар баробари ин, воситаҳои мавҷудаи муолиҷа ҳам аз сабаби самранокии нокифояи онҳо, ҳам аз сабаби таъсири аксаран инкишофёбандаи иловагӣашон талаботҳои пешниҳодшавандаро пурра қонеъ намуда наметавонанд. Аз ин сабаб барои баланд бардоштани сифати муолиҷаи беморони гирифтори ГБР солҳои охир доруҳои энзимотерапияи системавӣ – *вобэнзим* ва *флогэнзим* (таблитсаи 7) истифода бурда мешаванд. Дар тадқиқотҳои сершумор исбот карда шудааст, ки энзимҳои гидролитикӣ фаъолнокии як қатор ситокинҳои каблиилтиҳобиро (ИЛ-1В, ФНО-а, ИЛ-6 ва ғайра) ба танзим медароранд, ки дар патогенези ГБР нақши асосӣ мебозанд. Маълум аст, ки қобилияти ҷавоби масуниро барангезиш додани ситокинҳо аз бисёр ҷиҳатҳо аз дастгоҳи ретсептории ҳучайра-нишонаҳо вобаста аст, дар ин маврид пастшавӣ, зичии ретсепторҳо дар гишои ҳучайраҳо таъсири махсуси интерлейкинҳоро якбора паст ё бартараф менамояд.

Қобилияти фуру нишондани ретсепторҳои ситокини дар «хучайра-нишонаҳо» ва ба ин васила нигоҳ доштани гуншавии оптималии онҳо аз тарафи энзимҳо яке аз механизмҳои танзимкунанда мебошад, ки ба татбиқи оммавии таъсири зиддиилтиҳобии ситокинҳо дар дараҷаи системавӣ муқобилият менамояд.

Таблитсаи 7

Таркиби доруҳои энзимотерапияи системавӣ

Таркиб	ВОБЭНЗИМ	ФЛОГЭНЗИМ
Таркиб	ВОБЭНЗИМ	ФЛОГЭНЗИМ
ПанГБРтин	100мг	-
Папаин	60мг	-
Бромелин	45мг	90мг
Липаза	10мг	-
Амилаза	10мг	-
Трипсин	24мг	48мг
Химотрипсин	1мг	-
Рутозид	50мг	100мг

Доруҳои энзимотерапияи системавӣ ба ғаъолнокии молекулаҳои кафшеркунандаи синфҳои гуногун (селектинҳо, интегринҳо, иммуноглобулинҳо ва ғайра) таъсири танзимкунанда мерасонанд, ки ба ангиши (индуксия) ва нигоҳдории аксуламалҳои масунию илтиҳобӣ ҳангоми ГБР нақши муҳим доранд. Ҳоло самараҳои зиддиомосӣ, фибринолитикӣ ва танзимкунандаи масунияти энзимотерапияи системавӣ исбот карда шудааст. Ғайр аз ин муқаррар карда шудааст, ки таъиноти ҳамбастаи антибиотикҳо ва доруҳои энзимотерапияи системавӣ боиси зиёд шудани гуншавии воситаҳои химиотерапевтӣ дар зардоби хун, самаранокии табобат мегардад (таблитсаи 8). Аз ҷумла, таъиноти ҳамбастаи доруи зиддибактериявӣ ва вобэнзимбарои беморони ГБР-и урогениталӣ на фақат боиси беҳтаршавии манзараи клиникӣ беморӣ гардид, балки барои элиминатсияи нисбатан самараноки барангезанда мусоидат намуд.

**Гуншавии доруҳои зиддибактериявӣ дар
зардоби хуни беморони гирифтори ГБР пас аз 8 соати
баъди қабули доруҳо**

Таблитсаи 8

Номи дору	Гуншавии г/л антибиотик 1 антибиотик + вобензим		Баландшави %
Дискитсиклин	0,5	0,7	40
Амокситсиклин	1,2	1,5	25
Триметоприн	1,4	1,7	21
Тетратсиклин	0,9	1,1	21
Ампитсилин	0,4	0,5	25

Доҳил намудани доруи вобензим (флогэнзим) ба муолиҷаи маҷмӯии беморони гирифтори ГБР барои пастшавии нисбатан зоҳиршавандаи падидаҳои клиникию лаборатории фаъолнокии илтиҳобӣ (синдроми бандҳои СТЭ, СРБ, фибриноген, гуншавии фраксияҳои глобулинии сафедагӣ ва ғ.), ки барои аллакай дар ду ҳафтаи авали табобат то 50-75% паст намудани вояи ДНЗИ ва ба ин васила ҳеле паст намудани ҳатари пайдоиши «ДНЗИ-гастропатия» имконият дод. Ғайр аз ин, дар заминаи энзимотерапияи системавӣ таҳаммулпазирии бехтар ва паст намудани таъсироти иловагии доруҳои заминавӣ мушоҳида карда шуд, ки сифати ҳаёти беморонро ҳеле бехтар намуд. Таъсироти иловагӣ, ки қатъ намудани вобензимро (флогэнзимро) талаб намоянд, ба қайд гирифта нашуданд, ба истиснои тез-тез шудани истихроҷи фаълаи баъзе аз беморон.

Истифодаи доруҳои энзимотерапияи системавӣ дар омехтагӣ бо воситаҳои заминавӣ дар беморони дорои фаъолнокии баланди ГБР, мавҷудияти касолатҳои мағзисарӣ, хангоми шаклҳои музмини ГБР, ки ба табобат муковиматпазир мебошанд, бо мақсади баланд бардоштани интиҳоби доруи зиддибактериявӣ «хангоми таҳаммулпазирии суст ё самаранокӣ нокифояи воситаҳои ситостатикӣ» мувофиқи мақсад аст.

Хангоми фаъолнокии баланди ГБР таъин намудани *вобэнзим* бо вояи 21-30 драже дар як шабонарз бо тадричан паст намудани воя то нигоҳдоранда (5 драже 3 бор дар як рӯз) нишон дода шудааст. Хангоми табобати дуру дароз бехтараш флогэнзим 6-9 давра дар як шабонарӯз истифода бурда шавад. Доруро бод или наҳор на камтар аз 30-40 дақиқа то хӯрокхӯрӣ ё 2 соат пас аз хӯрокхӯрӣ истеъмол намудан лозим аст; доруҳо бояд ҳоида наshawанд ва бо миқдори зиёди об (150 мл) истеъмол карда шаванд. Давомноки табобат барои ҳар як бемор ба таври фардӣ аз тарафи духтури муолиҷакунанда муайян карда мешавад.

ИНТЕРФЕРОНОТЕРАПИЯ ВА ИНДУКТОРҲОИ ИНТЕРФЕРОНҲО

Солҳои охир ахборотҳо оид ба самаранокии хуби интерферонотерапия дар муолиҷаи маҷмӯи пайдоишаш хламидиявӣ пайдо шуданд. Аз ҷумла, истифодаи Интрон А дар заминаи табобати зиддибактериявӣ барои элиминатсияи нисбати самараноки барангезанда ва бехтар шудани манзараи клиники бемории асосӣ мусоидат намуд. Интрон А бо вояи 3 млн. ВОХ., ҳамагӣ 3-4 тазриқ дар як даври табобатӣ бо фосилаи 6-7 рӯз таъин карда шуд.

Дар баробари ин, интерферонотерапия як қатор таъсиротҳои иловагии ҷиддӣ (баланд шудани ҳарорати бадан, пурзӯршавии атралгия ва ғ.) низ мерасонад, ки истифодаи онро маҳдуд менамояд. Аз ин сабаб аллакай якчанд сол боз дар табобати маҷмӯи ГБР мо индуктори пастмолекулярӣ интерферонҳои эдогенӣ – *сиклоферонро*, ки ба синфи акридонҳо дохил мешавад ва дар ширкати ватании илмӣ технологияи «Полисан» истеҳсол мешавад, истифода мебарем.

Сиклоферон монотситҳо, макрофаҳо, Т- ва В-лимфотиситҳоро ҳосил намудани интерферонҳои экзогенӣ ба танзим медарорад, дар ин маврид зиёдшавии миқдори онҳо на танҳо дар хун ва моеъҳои биологӣ, балки дар узву бофтаҳои аз элементҳои лимфоидӣ бой (испурҷ, чигар, шуш, роҳи меъдаву рӯда) мушоҳида карда мешавад. Баланд шудани дараҷаи интерферонҳо ба элиминатсияи бехтари барангезандаҳои дохилихуҷайравӣ – вирусҳо,

хламидияҳо, микоплазмаҳо, ураплазмаҳо ва гайра хангоми таъин намудани сиклоферон дар омехтагӣ бо доруҳои зиддивирӯсӣ ва/ё зиддибактериявӣ мусоидат менамояд.

Сиклоферон ҳам таъсири бевосита ба ҳуҷайраҳои иммунокомпетентӣ ва ҳам бавосита тавассути зинаи ситокинӣ мерасонад. Аз ҷумла дору ҳосилшавии гранулоситҳоро аз ҳуҷайраҳои гузаштагони мағзиустухонӣ танзим менамояд, бо таъсири он фаъолнокии фаготиситарии нейтрофилҳо (иктидори бактерияофарии онҳо) дар натиҷаи баланд шудани коркарди шаклҳои фаъоли оксиген, инчунин фаъолнокии табиӣ киллерӣ зиёд мешавад. Қобилияти таъсири воявобастаи боздорандаи сиклоферон ба ҳосилшавии зиёди ситокинҳои қабилитиҳобӣ (ИЛ-1В, ФНО-а, ИЛ-8), инчунин барангезиши коркарди интерлейкинҳои қабилитиҳобӣ (ИЛ-4, ИЛ-10) диққатҷалбкунанда мебошад.

Сиклоферон ба беморони гирифтори ГБР дар шакли маҳлули 12,5% дохилимушакӣ ё дохиливаридӣ бо вояи 25 мг/шабонарӯз бо даври табобати 10-рӯза ё ду даври табобати 5-рӯза таъин карда мешавад. Хангоми зарурияти табобати нисбатан дуру дароз шакли курсмонанди дору бо вояи 300мг/шабонарӯз (даври табобати аз тарафи духтури муолиҷакунанда ба таври фардӣ барои ҳар бемор муайян карда мешавад ва аз 2 то 4 ҳафта ро ташкил медиҳад) истифода бурда мешавад.

Ба таври ҷузъӣ хангоми сирояти урогениталӣ *линименти 5% сиклоферон* дар шакли инстилляция ё фатилаҳо; ҳагоми касолати мултаҳима доруҳои катрагии чашмии *сиклоферон (полвиран)* истифода бурда мешаванд.

Сиклоферон аз тарафи беморон нағз таҳаммул карда мешавад, таъсироти пирогенӣ, мутагенӣ ва тератогенӣ надорад, бо сафедаҳои плазмаи хун кам алоқманд мешавад, дар организм нигоҳ дошта намешавад (99% дору тавассути гурдаҳо дар шакли тағйирнаёфта дар муддати 24 соат хориҷ мегардад).

УСУЛҲОИ ИЛОВАГӢ

Табобати маҷмуии ГБР истифодаи як қатор усулҳои иловагиро пешбинӣ менамояд, ки ба беморон

хангоми самаранокии нокифояи табобати анъанавӣ таъин карда мешаванд. Дар байни онҳо усулҳои беаҳғардонии хун хориҷабоданӣ: плазмафарез, гемосорбсия ва крио-плазмосорбсия мавқеи муҳим доранд. Истифодаи ин усулҳо бо имконияти аз гардиш хориҷ намудани ситокинҳои қабилитиҳои ва простагландинҳо, омилҳои бемориовари масунӣ, маволи антигенӣ асоснок гардидааст, ки боиси кам намудани таҳмили ҳучайраҳои системаи фаготистҳои моноклеарӣ мегардад ва ба барангезиши фаготситози эндогенӣ (дохилибаданӣ) мусоидат менамояд.

Мувофиқи мақсад будани истифодаи усулҳои беаҳғардонии хориҷабодани бо самти ислоҳкунии масуният, заҳрогинии амалиёт алоқманд карда мешавад. Барои беморон 4-5 амалиёти плазмаферез (гемосорбсия, криосорбсия) бо фосилаи 3-4 рӯз гузаронда мешавад.

Чи хеле ки қайд карда шуд, хангоми табобати тӯлонии зиддибактериявӣ ба беморони гирифтори ГБР таъин намудани воситаҳои зиддизамбуруғӣ (нистатин, дифлюкан, амфотеритсин-В ва ғайра), инчунин доруҳои муътадилкунандаи таркиби микрофлораи рӯда (хилакфорт, линекс, бактисуптил ва ғайра) барои профилактикаи (пешгирии) дисбактериоз зарур аст.

Ба мақсади беҳтар намудани гардиши рағҳои хурди хунгард дар бандҳои касалатёфта доруҳои рағӣ: курантил, пентоксифиллин, кислотаи никотинӣ ва ғайра) таъин карда мешаванд.

АЛГОРИТМҲОИ ТАБОБАТИ ГАЗАКГИРИИ БАНДИ РЕАКТИВӢ

Бо назардошти механизми бемориовари ГБР мо истифода бурдани *алгоритмҳои зерини усулҳои муолиҷа* пешниҳод менамоем. Хангоми мавҷуд будани синдроми бандҳо ва аломатҳои сирояти аз сар гузарондашуда (тестҳои мусбати серологӣ) ба беморон доруҳои зиддибактериявӣ (зиддивирӯсӣ, зиддизамбуруғӣ) вобаста ба ҳассосияти микрофлораи ҷудошуда ба онҳо, доруҳои зиддиинфeksiобии нестероидӣ аз гурӯҳи ингибиторҳои селективӣ СОГ-2 (селебрекс), инчунин доруҳои энзимотерапияи системавӣ (вобэнзим) таъин карда мешаванд.

Мо муаррифии клиникаи нақшаи муолиҷаи

зерини ГБР-и пайдоишаш хламидиявиرو гузарондем. Хангоми чарёни шадида сирояти хламидиявӣ : сумамед 0,5г дар рӯзи якум, сипас 0,25 г аз рӯзи 2-юм то 5-ум; ду даври табобати бо танаффуси 0,5 рӯза дар байни онҳо гузаронда мешавад, ки дар муддати он беморон 2 мл сиклоференро ҳамарӯза дохилимушакӣ қабул менамоянд. Аз рӯзи аввали табобат вобэнзим бо вояи 8 драже 3 бор дар як шабонарӯз таъин карда мешавад. Самранокии хориҷшавии хангоми истифодаи барномаи пешниҳодшудаи муолиҷӣ 75%-ро ташкил медиҳад.

Хангоми чараёни музмини сирояти хламидиявӣ: сумамед 0,5г дар рӯзи якум, сипас 0,25 г аз рӯзи 2-юм то 5-ум; се даври табобати бо танаффуси 5 рӯза дар байни онҳо гузаронда мешавад. Сиклоферон аз рӯзи аввали табобати зиддибактериявӣ 2 мл дохилимушакӣ ҳар рӯз дар муддати 10 рӯз, сипас даври такрорӣ табобат бо фосилаи 5-рӯза таъин карда мешавад. . Аз рӯзи аввали табобат вобэнзим бо вояи 7 драже 3 бор дар як шабонарӯз таъин карда мешавад.

Агар дар заминаи муолиҷа бо ДНЗИ дар муддаи ду-се ҳафта фаъолнокии баланди клиникаю лаборатории ГБР нигоҳ дошта шавад, пас глюкокортикоидҳо бо вояи 3050 мг/шабонарӯз бо даври кӯтоҳи табобатӣ ва минбаъд пурра қатъ намудани онҳо таъин карда мешаванд. Истифодаи «набз-табобат» дар варианти монотерапия бо метипред ё ҳамбастагии метипред ва сиклофосфан, усулҳои беаҳтардонии хориҷибаданӣ имкон дорад.

Ҳагоми ба шакли тӯлкашида ё музмин гузаштани беморӣ таъин намудани доруҳои заминавӣ ҳатмӣ аст.

Алгоритми зерин пешниҳод карда мешавад: делагил (плаквенил) ё сулфасалазин хангоми шаклҳои тӯлкашидаи ГБР, ки бо фаъолнокии начандон зиёд чараён меёбанд, метотрексат (азатиприн, имуран, сиклофосфан) хангоми шаклҳои вазнини чараёни ГБР ва даври табобатии дуру дароз бо сулфасализин хангоми чарёни хуруҷкунандаи беморӣ. Истеъмоли доруҳои заминавӣ бо таъин намудани доруҳои энзимотерапияи системавӣ (вобэнзим, флогэнзим) ҳамбастагӣ менамояд.

ТАБОБАТИ ЧУЗӢИ

Дар муолиҷаи маҷмӯии ГБР табобати чузӣ аҳамияти махсус пайдо мекунад, махсусан ҳангоми дар манзараи клиникӣ мавқеи асосӣ доштани моно- ва/ё олигоартрит (таблитсаи 9). Ҳангоми касолати бандҳои зону ва мавҷудияти синовит сӯзанҳалонии он (пунксия) амалӣ карда мешавад, ба таври максималӣ моеи зулолӣ бо тадқиқи минбаъдаи ситологӣ ҳориҷ карда мешавад. Ба назар гирифтани лозим аст, ки ҳангоми меъёр дар бандҳо миқдори наҷандон зиёди моеи зулолӣ мавҷуд аст ва он бо роҳи ламскунӣ ошкор карда намешавад. Зиёд шудани миқдори моеъро дар сатҳи бандҳо аз рӯи мавҷуд будани флюктуатсия муайян менамоянд.

Таблицаи 9

Муолиҷаи чузӣи беморони гирифтори ГБР

Тадохули дохилибандии доруҳо	
	- Дипроспан – 1 мл ба бандҳои китф ва зону, 0,5 мл – ба оринҷ, соиду панҷа ва зонуву попанҷа, барои даври табобатӣ 3-4 тадохул - Кеналог – 1 мл ба бандҳои калон, 0,5 мл ба миёна ва 0,25 мл ба хурд; 3-4 тазриқ барои даври табобатӣ бо фосилаи 10-14 рӯз - Тадохули ҳамбастаи дипроспан (воя аз бузургии бандҳо вобастагӣ дорад) ва сиклофосфан бо вояи 50-100 мг
Апликатсияи ДМСО, ДНЗИ ва финалгон	
	- Дар қисмати бандҳои касолатёфта маҳлули 50% ДМСО (дар оби муқаттар) алоҳида ё дар ҳамбастагӣ бо аналгин (0,5 г), гепарин (5000 Воx.), эуфиллин (1 мл маҳлули 24%), дипроспан (1 мл), кислотаи никотинӣ (1 мл) ҳар рӯз 25-30 дақиқа, 8-10 илочиё барои даври табобатӣ; - ДНЗИ дар шакли маохам, гел, крем ва ҳамираҳо дар қисмати бандҳои касолатёфта - Финалгон дар қисмати бандҳои касолатёфта
Илочиёҳои физиотерапевтӣ:	
	- Шуъзании ултрабунафиш бандҳо (ШУБ) - Фонофорези гидрокортизон ба таври чузӣ дар бандҳо - Майдонҳои магнитии басомадашӯн ултра- ва хеле баланди детсиметрӣ (СВЧ-ДМВ) ё сантиметрӣ (СВЧ-СМВ); - Табобати магнитию лазерӣ - Муолиҷа тавассути парафин ва озокерит - Варзиши муолиҷавӣ, махс

Барои фуру нишондани фаъолнокии ГБР тадохули дохилибандии глюкокортикоидҳо истифода бурда мешавад: 1 мл кеналог дар бандҳои калон, 0,25-

0,5 – дар миёна. Даври табобат 3-4 тазрикро бо фосилаи 10-14 рӯз дар бар мегирад. Самараи нисбатан зоҳиршаванда ва давомноки зиддиинтиҳобӣ ҳангоми тадуҳли дипроспан ба даст оварда мешавад. 1 мл сузпензия (ғизлати) обию кристаллии дипроспан ду моддаи ғаёл дорад: 2 г бетаметазони динатрии фосфат, ки дар бо ба осонӣ ҳал мешавад, тез ҷаббида мешавад ва самараи ғаврии муолиҷӣ мерасонад (қуллаи ҷамъшавӣ дар бофтаҳо пас аз якҷанд дақиқаи тадоҳули дору ба даст меояд) ва 5 мт-бетаметазон дипропионат, ки ба туғайли ҷаббиши оҳиста, метаболизатсияи тадриҷӣ ва давраи дуру дарози ихроҷшавӣ таъсири давомноки муолиҷавиро таъмин менамояд. Дипроспанро ба таври доҳилибандӣ, наздибандӣ, инчунин доҳилимушакӣ тадоҳул кардан мумкин аст. Вояи дору ҳангоми тадоҳули доҳили- ва наздибандӣ аз бузургии бандҳо вобастагӣ дорад: ба бандҳои китф ва зону 3 мл, ба бандҳои оринҷ, соиду панҷа ва зонуву панҷаи по – 0,5 мл тадоҳул карда мешавад. Ҳангоми бурсит, тендосиновит, кистаҳои зулолӣ вояи дору 0,25 то 1 мл, ҳангоми тадоҳули доҳилимушакӣ – 1 мл мебошад. Ҳангоми мавҷуд будани тағйиротҳои нумукунандаи пардаи зулолӣ самараи нисбатан зоҳиршаванда ҳангоми ба бандҳо ба таври ҳамбаста доҳил намудани дипроспан (бо ҳамон воя) ва сиклофосфан (50-100мг) ба даст оварда мешавад.

Тибқи маълумотҳои шахсӣ, ҳангоми тадоҳули доҳилибандии дипроспан дар 94% беморони гирифтори ГБР ҳеле кам шудани зоҳиршавии синдроми дард аллақай дар шабонарӯзи авали баъди сӯзанҳалонии бандҳо, дар 97% беморон – кам шудани варами бандҳои касолатёфта мушоҳида гардид. Бехтаршавии ҳолати функционалии бандҳои касолатёфта ва вобаста ба ин зиёд шудани ғаёлнокии ҷисмонӣ дар 100% ҳолатҳо муқаррар карда шуд. Самараи хуби клиникӣ ҳангоми истифодаи дипроспан, инчунин ҳангоми таъин намудани тазриқҳои доҳилимушакӣ (ҳангоми миозит ва ғастиит) мушоҳида гардид. Давомнокии самараи муолиҷавӣ ҳангоми тадоҳули наздибандии дипроспан ба ҳисоби миёна 4-5 ҳафтаро ташкил дод.

Дар хотир гирифта, лозим аст, ки ҳангоми тазриқи доҳилибандӣ ҳатари сироятнокшавии бандҳо вучуд дорад, ки онро бо қатъи риоя намудани қоидаҳои асептика (бесироятгардонӣ) ва антисептика пешгирӣ

намудан мумкин аст. Гайрираводид барои тадохули дохилибандии дору мавҷуд будан ё гумонбар шудан ба газакгирии банди сироятӣ, инчунин касолати римноки пӯст дар қисмати бандҳои касолатёфта мебошад.

Самараи хуб дар беморони ГБР ҳангоми истифодаи ҷузъии диметилсулфоксид (ДМСО) ба даст омад. Дору таъсири зиддиилтиҳобӣ, ташаннучовар дорад. Гайр аз ин, ДМСО қобилияти тавассути пӯст интиқол додани доруро дорад. ДМСО ба таври ҷузъӣ дар бандҳо дар шакли аппликатсияҳо истифода бурда мешавад: маҳлули 50% дар оби муқаттар алоҳида ё дар ҳамбастагӣ бо аналгин (0,5 г), гепарин (5000 воҳ.), гидрокортисон 12,5 мг, ҳар рӯз шабона, 5-7 илочиё барои даври табобатӣ.

Ҳангоми дардҳои нигоҳдошташудаи на он қадар шиддатнок дар бандҳо, махсусан ҳангоми моно-ва олигоартрит зиёд накардани вояи ДХНИ-и пероралӣ, балки истифода бурдани онҳо ба таври ҷузъӣ дар шакли малҳам (гел, крем, ҳамира) ба мақсад мувофиқтар аст. Самараи хуб ҳангоми таъин намудани креми «Долгит», гел ё ҳамираи «Ревмон» ва гайра мушоҳида карда шуд.

Ҳоло барои беморони гирифтори ГБР *финалгон* низ истифода бурда мешавад, ки аз омехтагии ду моддаи рагвасеъкунанда – нонивамид ва никобоксил иборат аст. Нонивамид дар натиҷаи барангезиши бевоситаи нӯғҳои ҳассоси асаб таъсири дардпаस्तкунанда дорад, никобоксил бошад боиси васеъшавии капиллярҳои мегардад ва эҳсоси гармиро ба вучуд меоварад. Бо таъсири финалгон равандҳои мубодилавӣ фаъол, рағҳои хунгард васеъ, маҷрои хун пурзӯр, тонуси мушакҳо паस्त мешавад.

Феналгон дар беморони гирифтори ГБР ба таври ҷузъӣ дар бандҳои дасту пой ва сутунмӯҳра ҳангоми дараҷаи I-II фаъолнокии беморӣ истифода бурда мешавад. Барои китъаи пӯсти андозааш чун қафи даст аз тубик фишор додани дору бо дарозии 0,5 см ва минбаъд молидани он дар пӯсти бандҳо ё сутунмӯҳраи касолатёфта тавсия дода мешавад. Феналгон ҳамчун воситаи самараноки барангезанда ва ҳамчун пластири гармӣ таъсир мерасонад, дар ин маврид кам шудани зоҳиршавии ташаннучи мушакҳо, миалгия ва атралгия мушоҳида карда мешавад. Дору аз тарафи беморон нағз таҳаммул карда мешавад, дар баъзе ҳолатҳо

аксуламалҳои алергии пӯст имкон доранд.

Касолати пӯст ва луобпардаҳо ҳангоми ГБР, одатан, муолиҷаи махсусро талаб намекунад, дар баробари ин ҳангоми инкишофи увеит муоинаи офталмологӣ зарур аст. Ҳангоми мавҷуд будани уретрит (простатит) дар мардҳо ва уретрит (бартолинит, колпит, эндосервитсит) дар занҳо машварати мутахассис (уролог, гинеколог) барои муайян намудани тактикаи табобати махсус нишон дода мешавад.

ТАБИАТШИФОӢ

Усулҳои табииатшифӣ дар муолиҷаи маҷмуии беморони ГБР, махсусан ҳангоми шаклҳои музминӣ беморӣ тавсия дода мешаванд. Илҷияҳои табииатшифӣ ба таври тафриқанок вобаста аз шиддатнокӣ ва зохиршавии раванди ҷузъии илтиҳобӣ таъин карда мешаванд.

Дар марҳилаи шадид ҳангоми мавҷуд будани синовит аз лаҳзаи воридшавии бемор ба статсионар ШУГ-и (УФО) бандҳо бо вояҳои эритемӣ (аз 3-4 то 7-8 боювояҳо вобаста аз бузургии бандҳои касолатёфта) бо 1 боювоя зиёд намудани он дар ҳар як шуззани навбатӣ таъин карда мешавад. Микдори ҷамъбасти илҷияҳо дар як банд набояд аз панҷ-шаш зиёд бошад. Ҳангоми синовитҳои инҷунин майдони электрикӣ УВЧ бо вояҳои олиготермӣ дар муддати 10-15 дақиқа, барои даври табобат 5-7 илҷия таъин карда мешаванд. Дар давраи шадиди ГБР истифодаи табобати омехта нисбатан самаранок аст – саравал майдони электрикии УВЧ, баъди 10-20 дақиқа пас аз он – ШУБ дар ҳуди ҳамон банд.

Ҳангоми ҷарёни музминӣ ГБР, мавҷуд будани тағйиротҳои нумукунандаи пардаи зулолии бандҳо ба таври ҷузъӣ электрофорези лидаза (гиалуронидаза) дар маҳлули буферӣ, фонофорези маҳлули калии йоддор, инҷунин табобати лазерӣ дар қисмати роғи бандҳо таъин карда мешавад. Давомнокии як илҷия 30 дақиқаро ташкил медиҳад, тъсир ба банд – то 5 дақиқа, даври табобат – 10-12 давра. Баръакси дигар усулҳои физиотерапевтӣ табобати лазерӣ ҳангоми газаки банди шадид низ истифода шуда метавонад. Табобати

магнитию лазерӣ (ТМЛ)- таъсири ҳамбастаи якбақта ба бофтаҳои касолатёфта тавассути майдони магнитӣ ва шуозании лазерӣ ҳамчунин самарбахш мебошад. Истифодаи ТМЛ барои воридшавии нисбатан чуқури мавҷҳои электромагнитӣ ба бофтаи бандҳо муосидат менамояд; ба мисли табобати лазерӣ ТМЛ дар ҳар гунна марҳилаи раванд истифода шуда метавонад. Ҳангоми ҷараёни музмини ГБР муолиҷаи гармой (аппликатсияи парафин ва озокерит), 10-15 илочи дар як даври табобат ба таври васеъ истифода бурда мешавад.

Барои барқарор намудани функсияи бандҳои касолатёфта варзиши муолиҷавӣ ва маҳс таъин карда мешавад. Варзиши муолиҷавӣ бояд пас аз маҳкам намудани илтиҳоби шадиди бандҳо истифода бурда шавад, дар айни замон ба ҳаракатҳои ғаёл ва ғаёлу ёридоханда диққати махсус дода мешавад. Меъёри қатъ намудани илочи пайдо шудан ё афзоиши дард дар бандҳо мебошад.

Муолиҷаи санаторию озоишгоҳии беморони гирифтори ҷараёни музмини ГБР ҳар сол берун аз давраи хуручи беморӣ амалӣ карда мешавад. Истифодаи обҳои радонӣ, ҳангоми хуручунии ГБР бо падидаҳои тарашшӯхӣ дар бандҳо-обҳои сероводородӣ, ҳангоми бартарӣ доштани тағйиротҳои нумукунанда ва контрактураҳои функционалии бандҳо – истифодаи аппликатсияҳои лойҳои табобатӣ нишон дода шудааст. Қайд кардан лозим аст, ки ҳангоми дар озоишгоҳ будан бемор бояд таҳти назорати духтур қарор дошта бошад ва қабули доруҳои заминавино қатъ накунад.

БИСТАРИГАРДОНӢ ВА МУОИНАИ ТИББИЮ ИҶТИМОӢИ БЕМОРОНИ ГИРИФТОРИ ҒАЗАҚГИРИИ БАНДИ РЕАКТИВИ

Баъди ҷавоб шудан аз статсионар беморони ГБР бояд таҳти назорати динамикии диспансерии тарбодшинос (духтури муолиҷи минтақавӣ) дар муддати 1 сол ҳангоми шакли шадиди беморӣ ва нисбатан дарозтар ҳангоми шакли музмини ГБР қарор дошта бошанд. Назорати клиникию лаборатории раванди ғаёлнокии масунию илтиҳобӣ бо иҷрои муоинаи умумиклиникии хун ва пешоб, ақсуламалҳои марҳилаи шадид ҳар як 3 моҳ гузаронда мешавад.

Ҳангоми шаклҳои тӯлкашида ва такроршавандаи ҷараёни ГБР ҳамчуни 1 бор дар 3 моҳ тадқиқи санҷишӣ барои сирояти хламидиявӣ гузаронда мешавад ва ҳангоми натиҷаҳои мусбат табobati зиддибактериявӣ оғоз карда мешавад. Агар бемор доруҳои ситостатикиро қабул мекарда бошад, назорати лаборатории нишондиҳандаҳои хун (микдори лейкоцитҳо, тромбоцитҳо, эритроцитҳо) моҳе як маротиба гузаронда мешавад.

Ҳангоми шаклҳои музмини ГБР беморон гоҳо ба табobati давомноки барқароркунанда эҳтиёҷ доранд.

Меёрҳои тиббии экспертизаи тиббӣ иҷтимоӣ (ЭТИ) ва экспертизаи корношоямӣ муваққатӣ (ЭКМ) инҳо мебошанд:

- Марҳилаи фаъолнокии беморӣ;
- Басомад ва вазнинии хуруҷҳо;
- Дараҷаи ҳалалёбии функсияи бандҳо, дигар узву системаҳо;
- Оризаҳо;
- Бемориҳои ҳамроҳикунанда

Беморони ГБР дар марҳилаи беҳбудии клиникаи лабораторӣ, инчунин ҳангоми бартрафшавӣ ё яқбора камшавии падидаҳои тарашшӯхӣ 8 бандҳо; ҳангоми набудан ё ихтилоли ками функсияи бандҳои касолатёфта; муътадилшавӣ ё паст шудан то меёр; фаънокии ба дараҷаи 1 мувофиқи нишондиҳандаҳои биохимиявии хун; набудани падидаҳои системавии ГБР қобили меҳнат шуморида мешаванд.

Меёрҳои муваққатан аз даст додани қобилияти қорӣ (МАҚ):

- Шиддатёбии беморӣ (ҳар гуна дараҷа)
- Пайдоиш ё пурзӯршавии синдроми бандҳо бо ихтилоли функсияи бандҳои касолатёфта;
- Пайдоиш ё пурзӯршавии тағйиротҳои тарашшӯхӣ функсияи бандҳои касолатёфта
- Ҳамчунин майдони электрики УВЧ бо вояҳои олиготермӣ дар муддати 10-15 дақиқа, барои даври табobati 5-7 илочия.

Дар марҳилаи шадиди ГБР истифодаи табobati

омехта нисбатан самаранок аст- сараввал майдони электрикии УВЧ таъин карда мешавад, баъди 10-20 дақиқа пас аз он ШУБ дар худи ҳамон бандҳо.

Дар давраи пастшавии илтиҳоби чузъи истифодаи ШУГ-и бандҳо, майдони тағйирёбандаи магнитии басомадаш баланд самаранок аст, инчунин фонофорези гидрокортисон, аналгин, эуфиллин ва дигар доруҳо истифода бурда мешавад.

Ҳангоми чараёни музмини ГБР, мавҷудияти тағйиротҳои нумукунандаи пардаи зулолии бандҳо ба таври чузъи электрофорези лидаза (гиалуронидаза) дар маҳлули буферӣ, фонофорези маҳлули калии йоддор, инчунин табобати лазерӣ дар қисмати роғи бандҳо таъин карда мешавад. Давмонокии як илочиё 30 дақиқаро ташкил медиҳад, вақти таъсир ба як банд – то 5 дақиқа, даври табобат – 10-12 сеанс. Баръакси дигар усулҳои шифотабии табобати лазерӣ ҳангоми газакгирии банди шадид истифода шуда метавонад. Табобати магнитикӣ лазерӣ (ТМЛ)- таъсири ҳамбастанӣ яквақта ба бофтаҳои касолатёфта тавассути майдони магнитӣ ва шузании лазерӣ ҳамчунин самарбахш мебошад. Истифодаи ТМЛ барои воридшавии нисбатан чуқури мавҷҳои электромагнитӣ ба бофтаи бандҳо муосидат менамояд; ба мисли табобати лазерӣ ТМЛ дар ҳар гунна марҳилаи раванд истифода шуда метавонад. Меъёри қатъ намудани илочиё пайдо шудан ё афзоиши дард дар бандҳо мебошад. Ҳангоми чараёни музмини ГБР муолиҷаи гармӣ (апликатсияи парафин ва озекирит), 10-15 илочиё дар як даври табобат ба таври васеъ истифода бурда мешавад.

Барои барқарор намудани функсияи бандҳои касолатёфта варзиши муолиҷавӣ ва маҳс таъин карда мешавад. Варзиши муолиҷавӣ бояд даррав пас аз маҳкам намудани илтиҳоби шадиди бандҳо истифода бурда шавад, дар айни замон ба ҳаракатҳои фаъол ва фаъолу ёридоханда диққати маҳсус дода мешавад. Меъёри қатъ намудани илочиё пайдо шудан ё афзоиши дард дар бандҳо мебошад.

Муолиҷаи санаторию озоишгоҳии беморони гирифтори чараёни музмини ГБР ҳар сол берун аз давраи хуруҷи беморӣ амалӣ карда мешавад. Истифодаи обҳои радонӣ, ҳангоми хуруҷкунии ГБР бо падидаҳои тараишӯхӣ дар бандҳо-обҳои сероводородӣ, ҳангоми бартарӣ доштани тағйиротҳои нумукунанда ва

контрактураҳои функционалии бандҳо – истифодаи
аппликаторҳои лойҳои табобатӣ нишон дода шудааст.
Қайд кардан лозим аст, ки ҳангоми дар осоишгоҳ будан
бемор бояд тахти назорати духтур қарор дошта бошад
ва қабули доруҳои заминавиро қатъ накунад.

АДАБИЁТ

1. Агабабова Э.Р., Артриты, связанные с инфекцией. // Клиническая ревматология. М., 1996. - С. 358-380.
2. Анохин В.А., Ревматические болезни и проблемы реабилитации. /Вопросы реабилитации при ревматических болезнях/ М., 1981. - С. 78-81.
3. Беневоленская А.И., Тананов А.Т., Кутьина Р.М., Ревматоидный артрит и антигены HLA. Вопросы ревматологии 1999. - № 2. - С. 9-15.
4. Биляева И.Б., Мазуров В.И. Реактивный артрит. Диагностика и лечение //Aqua vitas, - 2000. - №1. - С. 25-28.
5. Медико-социальная экспертиза при внутренних болезнях. Под ред. М.Н. Петрова. З.Д. Шварцмана-СПб, 1995. – С. 24-49.
6. Насонов Е.Л. Нестероидные противовоспалительное средства. М., 2000 г. -С. 143
7. Насонова В.А., Астапенко М.Г. Клиническая ревматология. М.: Медицина. - 2000 г. - С. 253-261.

8. Системная энзимотерапия. Современные подходы и перспективы. СПб – Некоммерческое партнерство издателей Санкт-Петербурга, 1999 стр. 224
9. Насонова В.А., Сигидин Я.А., Тернавский Я., Выкидал М. Фармакотерапия в ревматологии. М.: Медицина. - 1996. - С. 214
10. Шукурова С.М., Ахунова Н.Т. Фармакотерапия раннего ревматоидного артрита. Душанбе, 2003. – С. 35-48.

Матбааи А.И. Ҷ.Т. «Дониш»
ш. Душанбе, кӯчаи С. Айни 121, бинои 2



000844534

Китобхонаи миллии Тоҷикистон